

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APH – Atendimento Pré-Hospitalar
ATTS – Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio
BEMAD – Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres
BOA – Batalhão de Operações Aéreas
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
CBU – Coordenador de Bombeiros da Unidade
CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais S.A.
CIAD – Centro Integrado de Atendimento e Despacho
COBOM – Centro de Operações de Bombeiros
COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CVV – Centro de Valorização da Vida
EPI – Equipamento de Proteção Individual
EPR – Equipamento de Proteção Respiratória
Gu BM – Guarnição Bombeiro Militar
ITO – Instrução Técnica Operacional
MABOM – Manual de Bombeiros Militar
NAIS – Núcleo de Atenção Integral à Saúde
OMS – Organização Mundial da Saúde
PCMG – Polícia Civil de Minas Gerais
PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais
PMRv – Polícia Militar Rodoviária
PRF – Polícia Rodoviária Federal
RAPH – Relatório de Atendimento Pré-Hospitalar
RAPS – Rede de Atenção Psicossocial
REDS – Registro de Eventos de Defesa Social
RPA – Aeronave Remotamente Pilotada
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SAS – Seção de Assistência à Saúde
SCO – Sistema de Comando em Operações
SOF – Sala de Operações da Fração
SOU – Sala de Operações da Unidade

SUS – Sistema Único de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

UR – Unidade de Resgate

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 FINALIDADE	10
3 OBJETIVOS	10
4 CONCEITOS E DEFINIÇÕES	11
4.1 Conceitos relacionados aos atores da ocorrência	11
4.1.1 Abordador	11
4.1.2 Abordador auxiliar	11
4.1.3 Comandante da operação	11
4.1.4 Delimitadores	11
4.1.5 Tentante	12
4.2 Conceitos relacionados ao Sistema ATTS	12
4.2.1 Sistema de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio — Sistema ATTS	12
4.2.2 Abordagem de dissuasão	12
4.2.3 Abordagem tática	12
4.3 Conceitos relacionados ao comportamento suicida	12
4.3.1 Comportamento suicida	12
4.3.2 Pensamento suicida	13
4.3.3 Ideação suicida	13
4.3.4 Tentativa abortada	13
4.3.5 Tentativa interrompida	13
4.3.6 Tentativa de suicídio	13
4.3.7 Suicídio consumado	13
4.4 Conceitos relacionados à avaliação operacional do risco	13
4.4.1 Fatores de risco predisponentes	13
4.4.2 Fatores de risco precipitantes	13
4.4.3 Fatores de proteção	14
4.4.4 Risco de suicídio	14
4.5 Conceitos relacionados aos espaços e à comunicação	14
4.5.1 Díade	14
4.5.2 Espaços de comunicação	14
4.5.3 Zona social	14
4.5.4 Zona de aproximação	14
4.5.5 Zona interpessoal	15
4.5.6 Rapport ou conexão	15
4.5.7 Ferramentas de diálogo	15

4.6 Conceitos relacionados aos perfis comportamentais	16
4.6.1 Agressividade	16
4.6.2 Alucinação	16
4.6.3 Delírio	16
4.6.4 Crise psicótica	16
4.6.5 Perfil agressivo	16
4.6.6 Perfil depressivo	16
4.6.7 Perfil psicótico	16
4.7 Conceitos relacionados à rede e vulnerabilidades	17
4.7.1 Rede de Atenção Psicossocial — RAPS	17
4.7.2 Rede de apoio	17
4.7.3 Pessoa de confiança	17
4.7.4 Pessoa em condição de vulnerabilidade	17
4.8 Conceitos relacionados ao encerramento, exposição e pós-ocorrência	17
4.8.1 Saída honrosa	18
4.8.2 Efeito Werther ou efeito contágio	18
4.8.3 Posvenção	18
4.8.4 Primeiros Socorros Psicológicos	18
5 SISTEMA DE ABORDAGEM TÉCNICA A TENTATIVAS DE SUICÍDIO — SISTEMA ATTS	19
5.1 Acionamento	20
5.2 Deslocamento	23
5.3 Estabelecimento de viaturas	24
5.4 Isolamento	26
5.5 Avaliação de risco	27
5.6 Desenvolvimento	28
6 GERENCIAMENTO DE OCORRÊNCIAS DE ATTS	30
6.1 Funções primordiais	31
6.1.1 Comandante da operação	31
6.1.2 Abordador	32
6.1.3 Abordador auxiliar	32
6.1.4 Equipe de abordagem tática	32
6.1.5 Equipe responsável pela coleta de informações	33
6.1.6 Segurança	33
6.1.7 Delimitadores	33
6.2 Passagem e assunção de comando	34
6.3 SCO aplicado ao ATTS	34
6.4 Plano de Ação	34

6.5 Matriz operacional de gestão em ATTS	35
7 OUTRAS INSTITUIÇÕES NA CENA	37
7.1 Interlocutor ou abordador de outra instituição já vinculado ao tentante	37
7.2 Chegada de outras instituições durante a ocorrência	38
7.3 Equipes de saúde, SAMU e rede de urgência	38
7.4 PMMG, Polícia Penal e ocorrência com arma	39
7.5 Trânsito, concessionárias, energia elétrica, produto perigoso e outros apoios	40
7.6 Condutas gerais e conflitos de orientação	40
8 ABORDAGEM DE DISSUAÇÃO	42
8.1 Aproximação	43
8.2 Silêncio inicial	44
8.3 Apresentação pessoal	44
8.4 Perguntas simples	45
8.5 Perguntas complexas	46
8.6 Ferramentas de diálogo	47
8.6.1 Técnica do sucesso anterior	48
8.6.2 Ponte para o futuro	48
8.6.3 Ponte para o passado	48
8.6.4 Paráfrase resumida	48
8.6.5 Evitar frases de negação	49
8.6.6 Confrontação empática	49
8.6.7 Microdecisão segura	49
8.7 Perfis comportamentais na tentativa de suicídio	49
8.7.1 Perfil agressivo	49
8.7.2 Perfil depressivo	49
8.7.3 Perfil psicótico	49
8.8 Dinâmicas na abordagem	49
8.8.1 Troca do abordador	50
8.8.2 Uso do abordador auxiliar	50
8.8.3 Fadiga da equipe	50
8.8.4 Saída honrosa	50
8.8.5 Transição da abordagem de dissuasão para a abordagem tática	51
9 ABORDAGEM INCLUSIVA E COMUNICAÇÃO ADAPTADA	53
9.1 Diretrizes gerais de abordagem inclusiva	53
9.2 Comunicação adaptada	53
9.3 Crianças e adolescentes	54
9.4 Pessoas idosas	54

9.5 Pessoas com deficiência	55
9.6 Tentantes neurodivergentes	55
9.7 Mulheres e meninas em sua diversidade	56
9.8 Tentante em contexto de violência doméstica	57
10 ABORDAGEM TÁTICA	58
10.1 Princípios de emprego	58
10.2 Critérios de transição para abordagem tática	59
10.3 Preparação da equipe tática	59
10.4 Emprego conforme risco específico	60
10.4.1 Risco de precipitação ou ambiente vertical	60
10.4.2 Risco aquático	61
10.4.3 Risco de incêndio, explosão, fumaça ou atmosfera perigosa	61
10.4.4 Risco elétrico	61
10.4.5 Risco de enforcamento	62
10.4.6 Arma branca, objeto perfurocortante ou objeto de risco	62
10.4.7 Intoxicação exógena, ambiente fechado ou local trancado	62
10.4.8 Arma de fogo, refém ou risco de natureza policial	63
10.5 Fluxos de apoio à decisão	64
10.6 Condutas após a abordagem tática	64
11 ENTRADA NO AMBIENTE E CONTENÇÃO	65
11.1 Entrada no ambiente e entrada forçada	65
11.2 Contenção física	66
11.3 Contenção mecânica	66
11.4 Contenção farmacológica	66
12 TENTANTE COM LESÕES E SITUAÇÕES COM PRESUNÇÃO DE ÓBITO	68
12.1 Tentante com lesões	68
12.2 Situações com presunção de óbito	69
12.3 Procedimentos gerais	69
13 ENCERRAMENTO DA OCORRÊNCIA	71
13.1 Orientações aos familiares e rede de apoio	71
13.2 Condução para unidade de urgência e registro	72
13.3 Posvenção e cuidado pós-ocorrência	72
13.4 Imprensa, divulgação e prevenção do Efeito Werther	73
REFERÊNCIAS	74
APÊNDICE A — FLUXO GERAL DO SISTEMA ATTS	77
APÊNDICE B — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: TÉCNICA DO SUCESSO ANTERIOR	78
APÊNDICE C — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: PONTE PARA O FUTURO	79

APÊNDICE D — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: PONTE PARA O PASSADO	80
APÊNDICE E — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: PARÁFRASE RESUMIDA	81
APÊNDICE F — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: EVITAR FRASES DE NEGAÇÃO	82
APÊNDICE G — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: CONFRONTAÇÃO EMPÁTICA	83
APÊNDICE H — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: MICRODECISÃO SEGURA	84
APÊNDICE I — CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL DOS PERFIS	85
APÊNDICE J — PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS (PSP)	86
APÊNDICE K — PASSO A PASSO PARA O COMANDANTE DA OPERAÇÃO	87
APÊNDICE L — PASSO A PASSO PARA O ABORDADOR	88
APÊNDICE M — SEGURANÇA NO ATTS	89

1 INTRODUÇÃO

O atendimento a tentativas de suicídio constitui ocorrência sensível, complexa e de elevado impacto operacional, exigindo do Corpo de Bombeiros Militar atuação técnica, segura, humanizada e orientada à preservação da vida. Nessas ocorrências, a intervenção deve conciliar segurança da cena, proteção do tentante e das equipes, comunicação qualificada, avaliação contínua do risco e articulação com os serviços responsáveis pela continuidade do cuidado.

O suicídio é reconhecido como relevante problema de saúde pública, com repercussões sobre indivíduos, famílias, comunidades e instituições. A Organização Mundial da Saúde informa que mais de 720 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano e recomenda respostas multissetoriais de prevenção e cuidado (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2025). No Brasil, o panorama epidemiológico reforça a necessidade de respostas institucionais qualificadas e articuladas à rede de saúde e proteção social (BRASIL, 2024).

No âmbito dos Corpos de Bombeiros Militares, a evolução doutrinária do atendimento consolidou princípios relacionados à segurança, ao diálogo, à escuta, à formação de vínculo e à adoção de condutas proporcionais ao risco apresentado. Essa evolução permitiu organizar o atendimento sob uma perspectiva sistêmica, na qual a comunicação com o tentante, o gerenciamento da ocorrência, a segurança operacional e as intervenções necessárias devem ocorrer de forma coordenada e orientada à preservação da vida.

Nesse contexto, esta Instrução Técnica Operacional adota o Sistema de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio — Sistema ATTS como matriz doutrinária e operacional do CBMMG. O Sistema ATTS compreende duas linhas operacionais complementares: a abordagem de dissuasão, fundamentada na comunicação verbal e não verbal, na escuta e no emprego de ferramentas de diálogo; e a abordagem tática, de caráter excepcional, empregada quando presentes as condições e os critérios operacionais estabelecidos nesta norma.

O atendimento não se encerra com a retirada do tentante da situação de risco. Conforme as circunstâncias da ocorrência, deverão ser consideradas a avaliação pré-hospitalar, a integração com os serviços de saúde e proteção, o encaminhamento responsável, o registro adequado, a preservação da dignidade e da privacidade e as medidas pertinentes ao pós-ocorrência. A atuação bombeiro militar deverá, portanto,

observar os limites institucionais, as competências dos demais órgãos envolvidos e a necessária continuidade do cuidado.

Esta ITO busca, assim, estabelecer unidade de ação para o atendimento dessas ocorrências no CBMMG, reunindo diretrizes de segurança, gerenciamento, abordagem, integração institucional e encerramento, em consonância com os princípios de valorização da vida, responsabilidade, integridade, gestão de riscos e atuação ética que orientam a atividade institucional.

2 FINALIDADE

Esta Instrução Técnica Operacional tem por finalidade orientar a tropa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais na atuação em ocorrências envolvendo tentativa de suicídio, mediante procedimentos técnicos, humanizados e seguros, integrados ao Sistema de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio — Sistema ATTS, com foco na preservação da vida, na redução do risco e na segurança da cena.

3 OBJETIVOS

Constituem objetivos desta ITO:

- a) padronizar a terminologia e as linhas operacionais do Sistema ATTS no âmbito do CBMMG;
- b) orientar as fases do atendimento, as funções operacionais, o gerenciamento da cena e a articulação com instituições de apoio;
- c) estabelecer critérios de segurança, abordagem de dissuasão, transição e emprego da abordagem tática, contenção e encaminhamento;
- d) assegurar abordagem humanizada e inclusiva, com proteção da dignidade, da imagem, da privacidade e da saída honrosa do tentante;
- e) orientar a integração com atendimento pré-hospitalar, rede de saúde, familiares, pessoa de confiança e rede de apoio, observadas as competências e os fluxos locais;
- f) orientar o encerramento, o registro objetivo, a proteção de dados, a prevenção de exposição indevida e o cuidado pós-ocorrência.

4 CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para fins desta ITO, os conceitos deverão ser empregados em sentido operacional, com foco na atuação bombeiro militar, na segurança da cena, na comunicação com o tentante e na preservação da vida. Os termos foram organizados por blocos temáticos para favorecer consulta rápida, padronização doutrinária e aplicação prática pela tropa.

4.1 Conceitos relacionados aos atores da ocorrência

4.1.1 Abordador

Bombeiro militar responsável pela condução principal da comunicação verbal e não verbal com o tentante, mantendo postura calma, escuta sem julgamento, linguagem simples, controle emocional, leitura da cena e foco na redução do risco.

4.1.2 Abordador auxiliar

Bombeiro militar que acompanha o abordador, apoia a leitura da cena, observa sinais de risco, fadiga e resposta do tentante, repassa informações ao comandante da operação e poderá substituir o abordador quando tecnicamente necessário.

4.1.3 Comandante da operação

Bombeiro militar responsável pela coordenação geral da ocorrência, definição de funções, avaliação contínua do risco, organização da cena, acionamento de recursos, decisão sobre transição para abordagem tática e condução do encerramento operacional.

4.1.4 Delimitadores

Bombeiros militares equipados com material adequado ao cenário, cuja função é delimitar espacialmente o tentante em pontes, viadutos, estruturas elevadas, margens de risco ou locais semelhantes, buscando reduzir deslocamentos para áreas de maior risco e, quando tecnicamente viável, preparar condição segura para eventual abordagem tática.

4.1.5 Tentante

Pessoa que realiza tentativa de suicídio ou manifesta comportamento de risco suicida durante a ocorrência.

4.2 Conceitos relacionados ao Sistema ATTS

4.2.1 Sistema de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio — Sistema ATTS

Conjunto integrado de procedimentos técnicos, operacionais e comunicacionais destinados à atuação do CBMMG em ocorrências envolvendo tentativa de suicídio ou comportamento suicida em curso, compreendendo acionamento, deslocamento, segurança da cena, abordagem de dissuasão, abordagem tática, atendimento pré-hospitalar, encaminhamento, registro e posvenção, quando cabível.

4.2.2 Abordagem de dissuasão

Linha operacional verbal e não verbal do Sistema ATTS, baseada em vínculo, escuta, perguntas e ferramentas de diálogo, com a finalidade de favorecer a desistência voluntária da tentativa e conduzir o tentante ao encaminhamento seguro.

4.2.3 Abordagem tática

Linha operacional do Sistema ATTS empregada como recurso excepcional diante de alteração objetiva do risco que exija intervenção física, risco grave à segurança ou oportunidade tática segura para preservação da vida, mediante decisão do comandante da operação, em alinhamento com o abordador e com a equipe técnica disponível.

4.3 Conceitos relacionados ao comportamento suicida

4.3.1 Comportamento suicida

Conjunto de manifestações relacionadas à possibilidade de autolesão com intenção de morte, consideradas nesta ITO apenas para fins de avaliação operacional, proteção da cena, comunicação e encaminhamento.

4.3.2 Pensamento suicida

Pensamento relacionado à morte, ao desaparecimento ou à desistência de viver, sem necessariamente indicar intenção imediata de agir.

4.3.3 Ideação suicida

Elaboração mental relacionada à intenção de tirar a própria vida, cuja presença deverá ser considerada na avaliação operacional do risco.

4.3.4 Tentativa abortada

Situação em que o próprio tentante interrompe o ato antes da execução completa.

4.3.5 Tentativa interrompida

Situação em que a tentativa é impedida por terceiro ou por circunstância externa antes da consumação.

4.3.6 Tentativa de suicídio

Ato autoinfligido com intenção de morte, sem resultado fatal.

4.3.7 Suicídio consumado

Morte decorrente de ato autoinfligido com intenção de morrer.

4.4 Conceitos relacionados à avaliação operacional do risco

4.4.1 Fatores de risco predisponentes

Condições presentes na história do tentante que podem aumentar a vulnerabilidade ao comportamento suicida e auxiliar a avaliação operacional, sem constituir, isoladamente, critério para decisão ou diagnóstico.

4.4.2 Fatores de risco precipitantes

Condições ou acontecimentos recentes associados ao agravamento da crise e relevantes para compreender a situação atual e orientar a avaliação operacional.

4.4.3 Fatores de proteção

Condições pessoais, familiares, sociais, espirituais, institucionais ou ambientais que podem favorecer vínculo, segurança, continuidade do cuidado e adesão ao encaminhamento.

4.4.4 Risco de suicídio

Estimativa operacional da possibilidade de agravamento do comportamento suicida durante a ocorrência, considerando fala, comportamento, acesso ao risco, fatores precipitantes, fatores predisponentes, fatores de proteção, resposta à abordagem, comunicação verbal e não verbal, condições da cena e possibilidade de encaminhamento seguro.

4.5 Conceitos relacionados aos espaços e à comunicação

4.5.1 Díade

Relação comunicacional estabelecida entre abordador e tentante durante a abordagem de dissuasão.

4.5.2 Espaços de comunicação

Referências operacionais utilizadas pelo abordador para organizar a aproximação, preservar a segurança e regular a distância em relação ao tentante. Compreendem a zona social, a zona de aproximação e a zona interpessoal.

4.5.3 Zona social

Espaço inicial e mais afastado em relação ao tentante, destinado à observação, leitura da cena, controle de estímulos, coleta de informações e organização da aproximação.

4.5.4 Zona de aproximação

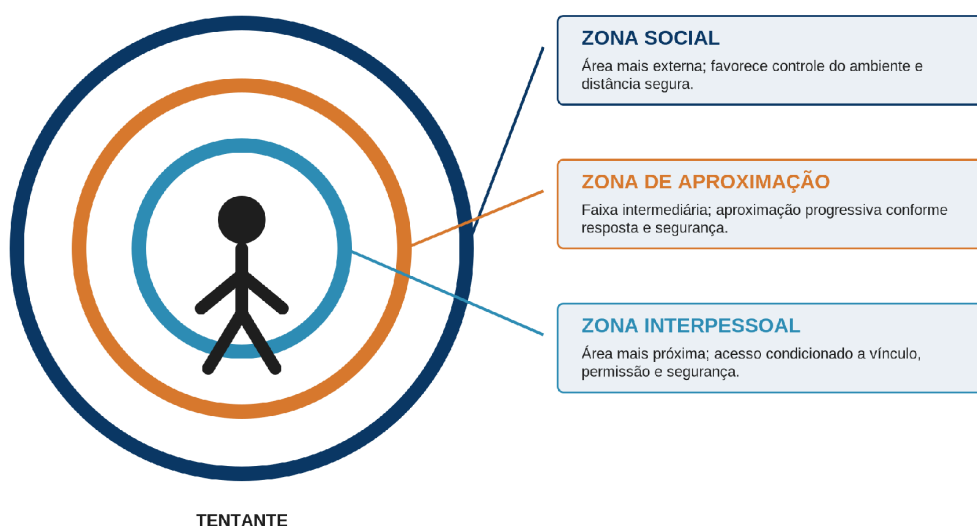
Espaço intermediário entre a zona social e a zona interpessoal, definido pela resposta do tentante, pelas características do ambiente e pela avaliação de segurança. O avanço deverá ser lento, gradual e interrompido diante de sinal de desconforto ou aumento do risco.

4.5.5 Zona interpessoal

Espaço de maior proximidade entre abordador e tentante, acessado somente quando houver vínculo, abertura comunicacional e avaliação favorável de segurança, sem aproximação precipitada ou pressão de terceiros.

Figura 1 — Espaços de comunicação em ocorrências de ATTS

ESPAÇOS DE COMUNICAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATTS



Representação esquemática sem definição de distâncias fixas; ajuste conforme a cena e a resposta do tentante.

4.5.6 Rapport ou conexão

Vínculo mínimo de confiança operacional estabelecido entre abordador e tentante, construído por presença, escuta, atenção, respeito, linguagem compatível e ausência de julgamento.

4.5.7 Ferramentas de diálogo

Recursos comunicacionais utilizados pelo abordador para formar vínculo, organizar a fala, reduzir tensão, identificar fatores de proteção, favorecer microações seguras e conduzir o tentante à desistência voluntária. Incluem, entre outras, técnica do sucesso anterior, ponte para o futuro, ponte para o passado, paráfrase resumida, evitar frases de negação, confrontação empática e microdecisão segura.

4.6 Conceitos relacionados aos perfis comportamentais

4.6.1 Agressividade

Comportamento de confronto ou ameaça, verbal ou não verbal, que pode se manifestar por agitação motora, violência dirigida a objetos, punhos cerrados, exigências, tom elevado, postura hostil, sentimento de perseguição ou resistência à aproximação.

4.6.2 Alucinação

Percepção sem estímulo externo correspondente, como ouvir vozes, ver pessoas inexistentes no local ou sentir algo no corpo sem estímulo real.

4.6.3 Delírio

Crença fixa mantida apesar de evidências contrárias, como acreditar estar sendo perseguido, vigiado ou submetido a missão externa.

4.6.4 Crise psicótica

Condição crítica observável em que alterações de percepção, pensamento e senso de realidade podem prejudicar comunicação, julgamento e segurança, exigindo abordagem calma, concreta e não confrontativa.

4.6.5 Perfil agressivo

Perfil comportamental caracterizado por fala hostil, tensão corporal, ameaça, resistência, irritabilidade, movimentos bruscos, desconfiança ou confronto, exigindo comunicação breve, calma, sem desafio e com atenção à segurança da equipe.

4.6.6 Perfil depressivo

Perfil comportamental caracterizado por choro, silêncio, lentificação, retraimento, culpa, desesperança, baixa resposta, pouca energia ou abandono da comunicação, exigindo fala suficiente para estabelecer diálogo, postura assertiva sem agressividade e estímulo à continuidade do cuidado.

4.6.7 Perfil psicótico

Perfil comportamental observável em cena no qual o tentante pode apresentar alteração relevante da percepção da realidade, fala desconexa, suspeita intensa, medo

persecutório, resposta a estímulos não compartilhados, desorganização, agitação, isolamento, silêncio incomum ou dificuldade de compreender comandos simples. A identificação desse perfil não constitui diagnóstico clínico e deverá servir apenas para adaptar a comunicação, reduzir estímulos, preservar a segurança e acionar apoio de saúde quando necessário.

4.7 Conceitos relacionados à rede e vulnerabilidades

4.7.1 Rede de Atenção Psicossocial — RAPS

Rede pública de atenção em saúde mental, álcool e outras drogas, composta por pontos de atenção do SUS e serviços articulados no território, a ser considerada para continuidade do cuidado após a ocorrência, conforme fluxo local e regulação competente.

4.7.2 Rede de apoio

Conjunto de pessoas, serviços, instituições ou vínculos que podem favorecer segurança, cuidado, acompanhamento e continuidade do encaminhamento do tentante, desde que sua participação não aumente o risco nem interfira negativamente na abordagem.

4.7.3 Pessoa de confiança

Pessoa indicada pelo tentante ou identificada pela guarnição como vínculo potencialmente protetivo, cuja aproximação somente deverá ocorrer mediante avaliação favorável do comandante da operação, do abordador e das condições de segurança da cena.

4.7.4 Pessoa em condição de vulnerabilidade

Pessoa que, por idade, deficiência, neurodivergência, doença, sofrimento psíquico, violência, dependência funcional, isolamento, situação de rua, discriminação, barreira comunicacional ou outro fator relevante, demande adaptação da abordagem, proteção adicional e possível acionamento de rede especializada.

4.8 Conceitos relacionados ao encerramento, exposição e pós-ocorrência

4.8.1 Saída honrosa

Condução do tentante para local seguro, com preservação da dignidade, privacidade, controle de exposição e continuidade do cuidado, evitando humilhação, espetáculo, comentários públicos ou sensação de derrota.

4.8.2 Efeito Werther ou efeito contágio

Possível efeito de imitação ou contágio associado à divulgação inadequada de suicídio ou tentativa de suicídio, especialmente quando há exposição de dados pessoais, método empregado, imagens, mensagens ou motivações presumidas.

4.8.3 Posvenção

Conjunto de ações de cuidado, orientação e suporte destinadas a familiares, sobreviventes, pessoas diretamente impactadas e bombeiros militares envolvidos após suicídio consumado.

4.8.4 Primeiros Socorros Psicológicos

Apoio humano inicial, prático e não invasivo, destinado a favorecer proteção, escuta, informação e conexão com apoio adequado, sem substituir atendimento especializado quando necessário.

5 SISTEMA DE ABORDAGEM TÉCNICA A TENTATIVAS DE SUICÍDIO — SISTEMA ATTS

O Sistema ATTS organiza a atuação da guarnição desde o acionamento até o encerramento da ocorrência, integrando segurança da cena, coleta de informações, abordagem de dissuasão, abordagem tática, atendimento pré-hospitalar, encaminhamento à rede de saúde e proteção, registro e posvenção, quando cabível.

O Sistema ATTS compreende duas linhas operacionais principais: a abordagem de dissuasão, baseada em comunicação verbal e não verbal, vínculo e ferramentas de diálogo; e a abordagem tática, empregada excepcionalmente quando a avaliação objetiva do risco indicar necessidade de intervenção física, risco grave à segurança ou oportunidade tática segura para preservação da vida.

Quadro 1 — Linhas operacionais do Sistema ATTS

Linha operacional	Finalidade	Condição de emprego
Abordagem de dissuasão	Reduzir tensão, formar vínculo, identificar fatores de risco/proteção e conduzir o tentante à desistência voluntária e ao encaminhamento seguro.	Primeira linha de atuação quando a segurança da cena permitir comunicação.
Abordagem tática	Intervir para preservação da vida diante de alteração objetiva do risco que exija intervenção física ou de risco grave à segurança.	Recurso excepcional, empregado mediante decisão do comandante da operação quando houver alteração objetiva do risco, risco grave à segurança ou oportunidade tática segura para preservação da vida.

Quadro 2 — Decisão inicial no Sistema ATTS

Situação observada	Linha prioritária	Conduta operacional
Cena segura e tentante comunicável	Abordagem de dissuasão	Iniciar aproximação, vínculo e ferramentas de diálogo.

Situação observada	Linha prioritária	Conduta operacional
Risco específico ou ambiental presente	Gestão da cena	Isolar, reduzir estímulos e acionar recurso adequado.
Lesão ou agravo clínico	Atendimento pré-hospitalar e dissuasão, se possível	Coordenar atendimento pré-hospitalar, segurança e comunicação.
Alteração objetiva do risco, risco grave ou oportunidade tática segura para preservação da vida	Abordagem tática	Preparar ou acionar intervenção proporcional, conforme decisão do comandante, mantendo a comunicação enquanto for segura e útil.
Tentante fora da área de risco	Encerramento	Realizar saída honrosa, conduzir à UPA, pronto-socorro ou hospital de referência, registrar a ocorrência e orientar a rede de apoio, conforme fluxo local.

5.1 Acionamento

O acionamento é a fase em que o CBMMG toma conhecimento da ocorrência. O COBOM/SOU/SOF deverá coletar as informações mínimas necessárias, manter comunicação respeitosa, orientar o despacho da Gu BM e preservar a dignidade do tentante, sem exposição indevida, julgamento ou transferência de responsabilidade ao solicitante.

a) coletar nome, idade aproximada, sexo, gênero ou nome social informado, quando relevante ao atendimento, localização precisa, ponto de referência, meio de acesso, telefone de contato e identificação do solicitante;

b) identificar se o solicitante é o próprio tentante, familiar, terceiro, instituição, rede de saúde, escola, PMMG ou outro órgão;

c) verificar comportamento observado, presença de terceiros, isolamento, local trancado, agitação, confusão, intoxicação, lesões, alteração de consciência e necessidade de atendimento pré-hospitalar;

d) identificar método informado ou suspeito, presença de armas, objetos de risco, altura, água, trânsito, energia elétrica, incêndio, produto perigoso, local confinado, agressor ou multidão;

e) se o tentante for o solicitante, manter comunicação calma, breve, respeitosa e sem rispidez até a chegada da Gu BM, evitando discussão, promessa absoluta, julgamento ou tentativa de resolver a ocorrência apenas por telefone;

f) não deverá ser dispensado chamado de tentativa de suicídio sem avaliação in loco por Gu BM, quando houver possibilidade de localização do tentante;

g) quando houver notícia por redes sociais, aplicativos ou terceiros, deverão ser coletados dados de localização, identificação do perfil, telefone de contato, vínculo com o tentante e demais informações úteis, repassando-as ao COBOM/SOU/SOF competente, conforme área de atuação;

h) repassar à Gu BM todas as informações coletadas, inclusive mudanças ocorridas durante o atendimento telefônico;

i) acionar instituições de apoio conforme o risco identificado, incluindo PMMG, SAMU, concessionária de energia, Conselho Tutelar, rede de saúde ou outros órgãos competentes, sem transferir ao solicitante a responsabilidade de resolver a ocorrência.

Quadro 3 — Informações essenciais no teleatendimento

Bloco do teleatendimento	Informações/conduas essenciais
Localizar	Endereço, ponto de referência, acesso, telefone de retorno e local exato do tentante.
Identificar risco	Método informado ou suspeito, altura, arma, água, fogo, eletricidade, trânsito, produto perigoso, intoxicação, local confinado, agressor e multidão

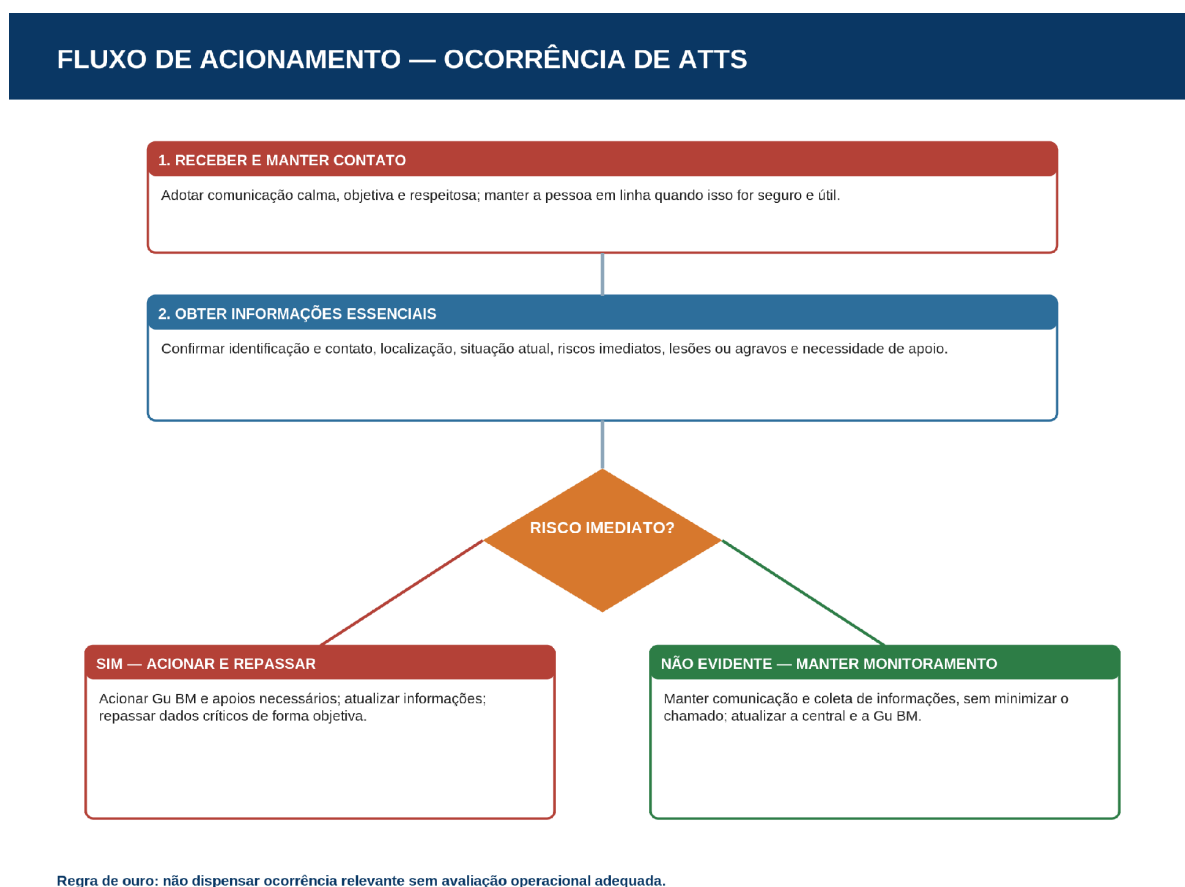
Bloco do teleatendimento	Informações/condutas essenciais
Identificar condição	Comunicabilidade, silêncio persistente, agitação, confusão, lesão, intoxicação e alteração de consciência.
Identificar terceiros	Solicitante, familiares, possível agressor, curiosos, adolescentes, PMMG, SAMU e rede de saúde já acionada.
Manter vínculo mínimo	Falar com calma, de forma breve e respeitosa, sem julgamento, sem promessa absoluta, mantendo a pessoa em linha quando seguro e possível.

Quadro 4 — Condutas desejáveis e não desejáveis no teleatendimento

Desejável no teleatendimento	Não desejável
Manter voz calma, objetiva e respeitosa.	Tratar o tentante ou solicitante com rispidez, ironia ou impaciência.
Coletar dados essenciais sem transformar a ligação em interrogatório.	Fazer perguntas excessivas, repetitivas ou culpabilizadoras.
Confirmar localização, método informado ou suspeito e riscos imediatos.	Minimizar a ocorrência ou orientar que “aguarde para ver”.
Manter o tentante em linha, se seguro e possível.	Prometer solução, sigilo absoluto ou tempo exato de chegada.

Desejável no teleatendimento	Não desejável
Repassar dados claros à Gu BM e à rede necessária.	Omitir informações sobre método, armas, agressor, lesões, intoxicação, alteração de consciência ou risco ambiental.

Figura 2 — Fluxo de acionamento em ocorrência de ATTS



5.2 Deslocamento

O deslocamento de viatura deverá ocorrer conforme previsão normativa e de trânsito vigente, com segurança para a Gu BM e terceiros. Nas proximidades do local, dispositivos sonoros e luminosos, exceto os previstos no Código de Trânsito Brasileiro, deverão ser reduzidos ou desligados quando isso não comprometer a segurança, a fim de evitar aumento de tensão na cena.

a) a Gu BM deverá deslocar-se com atenção ao cenário informado, preparando-se para abordagem de dissuasão, eventual abordagem tática, atendimento pré-hospitalar e isolamento;

b) o COBOM/SOU/SOF deverá atualizar a Gu BM durante o deslocamento, se surgirem novas informações sobre comportamento, localização, método informado ou suspeito, presença de armas, agressor, lesões, intoxicação, alteração de consciência ou risco ambiental;

c) o deslocamento deverá evitar aproximação ruidosa ou exposição desnecessária quando a situação permitir abordagem discreta;

d) deverá ser avaliada necessidade de UR, viatura de salvamento, viatura de combate a incêndio, autoescada, apoio policial, SAMU, concessionária de energia ou outro recurso compatível com a natureza da ocorrência e disponibilidade local;

e) a Gu BM deverá considerar rotas de acesso, ponto de estacionamento, rota de fuga, local de reunião e possibilidade de aproximação segura;

f) a Gu BM deverá evitar chegar ao local com sirenes, aglomeração de equipes ou movimentação ostensiva sem necessidade operacional.

5.3 Estabelecimento de viaturas

O estabelecimento de viaturas deverá reduzir estímulos, preservar acessos, manter segurança e permitir emprego operacional compatível com o método informado ou suspeito. A posição das viaturas deverá considerar o local da ocorrência, o campo visual do tentante, a necessidade de isolamento, ancoragem, barreira, anteparo, atendimento pré-hospitalar, abordagem tática, retirada assistida e condução segura.

a) estacionar as viaturas em local seguro, fora de áreas sujeitas a explosão, incêndio, queda de objetos, arremesso de materiais, risco elétrico, contaminação, agressor ou interferência direta do tentante;

b) evitar concentração de viaturas, militares, familiares, curiosos e terceiros no campo visual imediato do tentante, salvo necessidade técnica justificada pelo comandante da operação;

c) em ocorrências envolvendo tentante em torres energizadas ou outros cenários com risco elétrico, estacionar as viaturas em local tecnicamente seguro, fora de áreas sujeitas à queda de fios, cabos, objetos ou partes da estrutura e de zonas com risco de

energização ou eletrocussão, observando as zonas de risco, controlada e livre previstas na ITO específica, bem como a orientação da concessionária;

d) utilizar viaturas como ponto de ancoragem somente quando houver indicação técnica, avaliação da equipe de salvamento, compatibilidade do veículo, estabilidade do terreno e ausência de improvisação insegura;

e) utilizar viaturas como barreira ou anteparo apenas quando tecnicamente indicado, sem bloquear rotas de acesso, retirada, atendimento pré-hospitalar, SAMU, apoio policial ou recursos especializados;

f) em ocorrências com risco de precipitação, avaliar o posicionamento de viatura de salvamento, autoescada, plataforma ou viatura de maior porte como apoio operacional, barreira visual ou anteparo, conforme disponibilidade, altura, terreno, segurança e decisão do comandante da operação;

g) em ocorrências com risco de incêndio, explosão, fumaça, produto perigoso ou atmosfera tóxica, posicionar viaturas fora da área de risco, considerando direção do vento, isolamento, EPI/EPR, recursos de combate a incêndio, equipe especializada e corredor de descontaminação, quando aplicável;

h) em ocorrências com risco aquático, margem instável, ponte, barragem, curso d'água ou local de difícil acesso, posicionar viaturas de forma a preservar área de trabalho para salvamento, acesso de embarcação ou equipamento, rota de retirada e atendimento pré-hospitalar;

i) manter rota livre de entrada e saída para UR, SAMU ou outro recurso de saúde, especialmente quando houver lesão, intoxicação, alteração de consciência, crise psicótica, agitação intensa ou necessidade de avaliação clínica;

j) evitar movimentação de viaturas durante a abordagem de dissuasão, salvo necessidade operacional, devendo qualquer reposicionamento ser comunicado ao comandante da operação e realizado sem aumento desnecessário de tensão na cena.

Quadro 5 — Estabelecimento de viaturas

Desejável no estabelecimento	Não desejável
Posicionar viaturas fora do campo visual imediato do tentante e de áreas de risco, preservando acesso e segurança.	Bloquear acesso de resgate ou criar aglomeração visual diante do tentante.

Desejável no estabelecimento	Não desejável
Usar viatura como ancoragem, barreira ou anteparo apenas quando houver indicação técnica.	Improvisar ancoragem ou anteparo sem avaliação de segurança.
Manter comunicação entre comandante, abordador e equipes de apoio.	Movimentar viaturas durante a abordagem sem necessidade ou sem aviso.
Prever rota de retirada, condução assistida e acesso para APH/SAMU.	Estacionar em local exposto a queda, fogo, eletricidade, produtos perigosos, contaminação ou agressor.

5.4 Isolamento

O isolamento deverá reduzir curiosos, ruídos, filmagens, interferências e estímulos que aumentem a tensão da cena, contribuindo para a segurança operacional, a preservação da dignidade do tentante e a prevenção do Efeito Werther.

a) isolar o local com cones, fitas zebradas, cordas, viaturas ou outros meios disponíveis, conforme características do cenário, risco identificado e orientação do comandante da operação;

b) familiares, conhecidos, solicitantes e terceiros deverão permanecer fora da área de risco, salvo decisão técnica excepcional do comandante da operação, quando houver utilidade operacional, vínculo positivo e ausência de aumento do risco;

c) a imprensa e pessoas não envolvidas deverão permanecer fora da área operacional de isolamento definida pelo comandante da operação, sem interferir na comunicação, na abordagem ou na segurança da cena, e não deverão ter acesso a dados pessoais, imagens, mensagens, método utilizado, falas do tentante ou detalhes da abordagem, observadas as diretrizes de prevenção do Efeito Werther;

d) quando houver suspeita de violência doméstica, coerção, ameaça ou interferência negativa, o possível agressor deverá ser mantido afastado do tentante e da área de abordagem, com acionamento de apoio policial quando necessário;

e) o isolamento deverá preservar acessos, rotas de retirada e área de trabalho para viaturas, atendimento pré-hospitalar, SAMU, PMMG e demais recursos necessários;

f) considerar interdição total ou parcial de via pública, ponte, passarela, edificação, área comum, margem, trilha, espaço coletivo ou outro ambiente, conforme necessidade operacional;

g) a área de isolamento poderá ser ampliada ou reduzida no desenvolvimento da ocorrência, conforme avaliação contínua do comandante da operação;

h) a delimitação da cena deverá considerar área de risco, área de apoio, ponto de comando e local seguro para familiares ou rede de apoio, conforme características do cenário;

i) havendo apoio de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, agentes de trânsito, Guarda Civil Municipal ou outras instituições, estas poderão ser orientadas quanto ao isolamento, bloqueio, desvio, controle de fluxo e restrição de acesso, conforme local e necessidade;

j) orientar, quando necessário e possível, que pessoas próximas não registrem, transmitam ou divulguem imagens, áudios ou vídeos da ocorrência, preservando a dignidade do tentante e evitando exposição indevida;

k) orientar, quando necessário, que induzir, instigar ou auxiliar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação constitui crime previsto na legislação vigente;

l) helicópteros, drones ou outros meios aéreos não autorizados deverão ser evitados sobre a área da ocorrência, quando puderem interferir na comunicação, aumentar exposição, produzir estímulo adicional ou comprometer a segurança;

m) o emprego de RPA pelo CBMMG deverá observar ITO específica e somente ocorrer quando contribuir para consciência situacional, segurança operacional ou tomada de decisão, sem aumentar estímulo, exposição ou risco ao tentante.

5.5 Avaliação de risco

A avaliação de risco deverá ser contínua, dinâmica e orientada à preservação da vida, à segurança da equipe e ao controle da cena. O comandante da operação deverá rastrear, reduzir ou neutralizar riscos compatíveis com o método informado ou suspeito, o comportamento do tentante, o ambiente e os recursos disponíveis.

- a) avaliar risco iminente, método disponível, acesso a meios, proximidade do ponto crítico, comportamento, ambivalência, agitação, intoxicação, lesão, exaustão e resposta ao diálogo;
- b) considerar fatores de proteção, pessoa de confiança, vínculos, crenças, responsabilidades, abertura à comunicação e aceitação de microações seguras;
- c) avaliar simultaneamente risco ao tentante, à equipe, a terceiros e ao ambiente, incluindo altura, água, trânsito, fogo, eletricidade, produto perigoso, arma, agressor, multidão, contaminação, intoxicação, local confinado e instabilidade estrutural;
- d) considerar que a ocorrência envolvendo comportamento suicida deverá ser tratada como potencialmente insegura até avaliação em sentido contrário, mantendo vigilância contínua mesmo quando o tentante aparentar cooperação;
- e) observar objetos ocultos, materiais arremessáveis, possibilidade de fuga, deslocamento abrupto, queda, agressão, acesso a áreas de maior risco ou mudança repentina de comportamento;
- f) reavaliar continuamente a necessidade de manutenção da abordagem de dissuasão, preparação tática ou transição para abordagem tática;
- g) considerar que a presença de lesão, atendimento de saúde ou aparente calma do tentante não elimina automaticamente o risco suicida;
- h) registrar informações relevantes de risco e proteção de forma objetiva, sem juízo de valor e sem exposição indevida;
- i) manter atenção a sinais de agravamento ou fechamento do canal de comunicação, como aproximação ao ponto de risco, interrupção brusca das respostas, despedida, agitação súbita, gesto preparatório, recusa persistente de microações seguras ou aumento da impulsividade;
- j) acionar recursos adicionais sempre que o risco ultrapassar a capacidade da guarnição presente.

5.6 Desenvolvimento

O desenvolvimento da ocorrência deverá integrar abordagem de dissuasão, segurança, coleta de informações, preparação tática, atendimento pré-hospitalar, isolamento, controle de estímulos e articulação com instituições de apoio.

a) remover ou afastar, quando possível, pessoas e objetos que aumentem poluição sonora, poluição visual, exposição indevida ou risco operacional, preservando o espaço de comunicação entre o abordador e o tentante;

b) reduzir estímulos desnecessários, como ruídos, luzes, sirenes, movimentação de equipes, aproximações simultâneas, filmagens, aglomeração, interferência de familiares, curiosos ou terceiros;

c) acionar mais equipes de bombeiros militares ou outras instituições, como SAMU, PMMG, PCMG, PRF, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Penal, concessionárias, Defesa Civil, agentes de trânsito, Guarda Civil Municipal ou outros órgãos, conforme risco identificado e necessidade operacional;

d) conferir o uso de EPI e equipamentos compatíveis por todos os participantes da ocorrência, conforme função exercida e risco presente;

e) considerar evacuação total ou parcial do local, conforme risco ambiental, ameaça à coletividade, possibilidade de explosão, incêndio, produto perigoso, instabilidade estrutural, agressor, multidão ou outro fator relevante;

f) manter a abordagem de dissuasão enquanto for segura, útil e tecnicamente indicada, preservando o vínculo e evitando ruptura desnecessária da comunicação;

g) preparar a abordagem tática de forma discreta quando houver risco de agravamento, sinais de suicídio iminente, fechamento abrupto do canal de comunicação ou oportunidade tática segura;

h) a equipe tática deverá permanecer em condição de pronto emprego, quando indicada, sem exposição desnecessária e sem antecipar movimentos que possam ser percebidos pelo tentante como ameaça;

i) as decisões deverão ser comunicadas internamente com objetividade, preservando unidade de comando, clareza de funções e segurança da diáde abordador-tentante;

j) após a redução do risco, a guarnição deverá providenciar saída honrosa, atendimento pré-hospitalar quando necessário, condução à unidade de urgência, registro e orientações à família ou rede de apoio.

6 GERENCIAMENTO DE OCORRÊNCIAS DE ATTS

O gerenciamento das ocorrências de ATTS deverá priorizar a preservação da vida, a segurança da cena, a proteção da equipe, a coordenação dos recursos e a unidade de ação. A ocorrência deverá ser organizada de modo a permitir abordagem de dissuasão, preparação discreta para abordagem tática quando indicada, atendimento pré-hospitalar quando necessário e articulação com instituições de apoio.

A guarnição deverá solicitar apoio sempre que houver risco ao tentante, à equipe, a terceiros ou condição específica que ultrapasse a capacidade operacional dos recursos presentes.

Sem prejuízo da aplicação do SCO vigente no CBMMG, as ocorrências de ATTS possuem características específicas que deverão ser observadas pelo comandante da operação, conforme o Quadro 6.

Quadro 6 — Passo a passo inicial do comandante da operação

Momento	Conduta operacional
Organização inicial	Designar abordador, abordador auxiliar, coleta de informações, segurança, isolamento e delimitadores, quando necessários.
Preparação tática	Avaliar necessidade de abordagem tática, definir sinal, palavra-senha ou comunicação interna e conferir posição da equipe.
Controle da ocorrência	Acompanhar a abordagem, preservar o canal de comunicação, controlar terceiros e reavaliar riscos.
Encerramento	Garantir saída honrosa, condução à unidade de urgência, registro e cuidado pós-ocorrência, quando cabível.

6.1 Funções primordiais

A equipe deverá organizar-se, conforme o cenário e os recursos disponíveis, em comandante da operação, abordador, abordador auxiliar, equipe de abordagem tática, coleta de informações, segurança e delimitadores, quando necessários.

6.1.1 Comandante da operação

a) o comandante da operação deverá ser o militar que assumir formalmente a coordenação da ocorrência, observadas a precedência, a função exercida e a organização operacional;

b) deverá definir abordador, abordador auxiliar, segurança, coleta de informações, equipe tática, delimitadores, isolamento e local de concentração dos recursos;

c) deverá estabelecer, quando houver possibilidade de abordagem tática, sinal, palavra-senha ou comunicação interna, em alinhamento com o abordador e a equipe tática;

d) deverá definir ponto de comando, rotas de retirada/escape, pontos de segurança, isolamento, posicionamento de viaturas e local para atendimento após a saída do ponto de risco;

e) o acionamento tático deverá decorrer de decisão do comandante da operação, em alinhamento com a leitura do abordador, quando houver alteração objetiva do risco que exija intervenção física, risco grave à segurança ou oportunidade tática segura para preservação da vida;

f) deverá coordenar a integração com PMMG, SAMU, PCMG, Polícia Penal, concessionárias, órgãos de trânsito, Defesa Civil ou outros órgãos, conforme o risco identificado.

6.1.2 Abordador

a) o abordador deverá ser, preferencialmente, bombeiro militar capacitado em ATTS ou com experiência em comunicação em crise, devendo sua escolha considerar também o vínculo já existente, a aceitação e a resposta do tentante, as características da ocorrência e a disponibilidade operacional, sem preferência ou regra rígida baseada

no sexo do militar, mantendo postura atenciosa, respeitosa, calma, observadora e sem julgamento;

b) antes da aproximação, deverá receber informações relevantes sobre fatores de risco, fatores de proteção, método informado ou suspeito, rede de apoio, possível agressor e riscos da cena;

c) durante a abordagem, deverá buscar formar vínculo, escutar, formular perguntas adequadas, utilizar ferramentas de diálogo e observar comunicação verbal e não verbal do tentante;

d) uma vez estabelecido vínculo, este deverá ser preservado até o encerramento ou até que a troca do abordador seja tecnicamente necessária.

6.1.3 Abordador auxiliar

a) o abordador auxiliar deverá acompanhar o abordador, observar a cena, apoiar a leitura comportamental e servir como reserva em caso de necessidade de troca;

b) deverá auxiliar na identificação de fadiga, sinais de risco, abertura ou fechamento comunicacional e repassar informações discretamente ao comandante da operação;

c) apenas o abordador deverá falar com o tentante, salvo decisão técnica justificada, evitando múltiplos interlocutores simultâneos.

6.1.4 Equipe de abordagem tática

a) a equipe de abordagem tática deverá ser composta, preferencialmente, por bombeiros militares com qualificação compatível com o método informado ou suspeito e com o risco presente;

b) deverá permanecer em condição de pronto emprego, sob coordenação de oficial ou graduado, mantendo comunicação com o comandante da operação;

c) somente deverá intervir mediante ordem do comandante da operação ou diante de necessidade imediata de preservação da vida, quando não houver tempo útil para nova deliberação;

d) deverá priorizar segurança, oportunidade tática segura, menor dano possível e preservação da continuidade do cuidado após a contenção.

6.1.5 Equipe responsável pela coleta de informações

A coleta de informações deverá ser realizada por militar ou equipe designada, utilizando mais de uma fonte sempre que possível e repassando ao comandante da operação e ao abordador dados relevantes sobre forma de identificação, contexto, fatores de risco, fatores de proteção, uso de substâncias, histórico operacionalmente relevante, possível agressor, pessoa de confiança, rede de apoio e riscos da cena.

6.1.6 Segurança

a) o responsável pela segurança deverá fiscalizar EPI, isolamento, controle de acesso, imprensa, curiosos, trânsito, rotas de retirada/escape, riscos ambientais e possibilidades de dano à guarnição, ao tentante e a terceiros;

b) qualquer condição que afete a segurança deverá ser comunicada imediatamente ao comandante da operação;

c) a segurança deverá considerar os eixos aplicáveis: altura, água, fogo, explosão, eletricidade, produto perigoso, arma, local confinado, trânsito, multidão, agressor, intoxicação, lesão e instabilidade estrutural.

6.1.7 Delimitadores

Bombeiros militares designados para apoiar o controle espacial da cena em locais de risco, especialmente ambientes verticais ou áreas com possibilidade de deslocamento para ponto crítico.

a) posicione os delimitadores conforme avaliação de segurança e orientação do comandante da operação;

b) mantenha observação contínua dos deslocamentos do tentante, sem interferir na comunicação do abordador;

c) integre sua atuação à segurança e à equipe tática, preservando rota de retirada e evitando movimentos que aumentem a tensão.

6.2 Passagem e assunção de comando

Na transferência de comando, o militar que deixa a função deverá repassar, de forma objetiva, as informações necessárias à continuidade segura da operação.

- a) informe situação atual, riscos identificados e alterações relevantes da cena;
- b) informe a linha operacional em curso, resposta do tentante e ações já realizadas;
- c) informe funções designadas, recursos disponíveis, apoios acionados e necessidades pendentes;
- d) informe a preparação tática existente, critérios já discutidos e forma de comunicação interna definida, quando aplicável;
- e) confirme prioridades imediatas e decisões que demandem reavaliação pelo novo comandante.

6.3 SCO aplicado ao ATTS

O Sistema de Comando em Operações deverá ser utilizado como ferramenta de comando, controle e coordenação em ocorrências de ATTS que demandem múltiplos recursos, longa duração, atuação interinstitucional, risco elevado ou necessidade de organização formal das funções. Sua aplicação deverá favorecer segurança, unidade de comando, comunicação, emprego racional de recursos, articulação com instituições de apoio e registro objetivo das decisões.

6.4 Plano de Ação

- a) o comandante da operação deverá estabelecer Plano de Ação simples, situacional e revisável, compatível com a gravidade, duração e complexidade da ocorrência;
- b) o Plano de Ação deverá indicar situação da ocorrência, objetivo prioritário, funções, riscos, recursos disponíveis, critérios de transição para abordagem tática, saída honrosa, condução à UPA, pronto-socorro ou hospital de referência e registro;
- c) em ocorrências complexas, prolongadas ou interinstitucionais, o plano poderá ser verbalmente estruturado ou registrado de forma resumida, preservando unidade de comando e clareza de funções;
- d) o plano deverá ser atualizado conforme comportamento do tentante, resposta à abordagem, mudança de risco, chegada de novos recursos ou necessidade de substituição de função.

6.5 Matriz operacional de gestão em ATTS

A matriz operacional de gestão em ATTS poderá ser utilizada pelo comandante da operação para organizar funções, recursos, comunicação e critérios de decisão, conforme a complexidade da ocorrência, sem burocratizar ocorrências simples.

Quadro 7 — Matriz operacional de gestão em ATTS

Campo	Conteúdo mínimo
Situação	Local, método informado ou suspeito, comportamento do tentante, riscos, terceiros, recursos disponíveis e instituições presentes.
Objetivos	Preservar a vida, reduzir risco, isolar perímetro, manter unidade de comando, preservar dignidade e conduzir à unidade de urgência.
Funções	Definir quem comanda, quem aborda, quem apoia, quem coleta informações, quem faz segurança e quem atua tecnicamente.
Recursos	Viaturas, EPI, equipamentos, comunicação, iluminação, atendimento pré-hospitalar, SAMU, apoio policial, concessionárias e rota de retirada.
Comunicação	Canal entre comandante, abordador, abordador auxiliar, equipe tática, segurança, coleta de informações e instituições de apoio.

Campo	Conteúdo mínimo
Encerramento	Saída honrosa, encaminhamento, registro, preservação de imagem, prevenção do Efeito Werther e cuidado pós-ocorrência, quando cabível.

7 OUTRAS INSTITUIÇÕES NA CENA

Ocorrências envolvendo tentativa de suicídio poderão exigir atuação multiprofissional e interinstitucional, conforme risco identificado, agravo clínico ou traumático, violência doméstica, trânsito, eletricidade, produto perigoso, local de difícil acesso ou necessidade de atendimento de saúde. Cada instituição deverá atuar dentro de sua competência, preservada a unidade de ação e a coordenação da dimensão bombeiro militar da ocorrência.

O comandante da operação deverá organizar a cena desde o início, preservando unidade de comando, definição de funções e controle dos interlocutores, de modo a evitar ruídos, sobreposição de falas e interferências que comprometam a abordagem de dissuasão.

A guarnição BM deverá isolar a área e controlar o ambiente, protegendo a diáde abordador-tentante e impedindo que curiosos, ruídos, filmagens ou interferências externas comprometam o vínculo comunicacional e a segurança da cena.

Toda instituição que chegar à cena deverá ser recebida e orientada pelo comandante da operação ou militar designado, a fim de preservar unidade de ação, controle dos interlocutores, segurança da cena e compatibilidade das ações com a estratégia em curso.

7.1 Interlocutor ou abordador de outra instituição já vinculado ao tentante

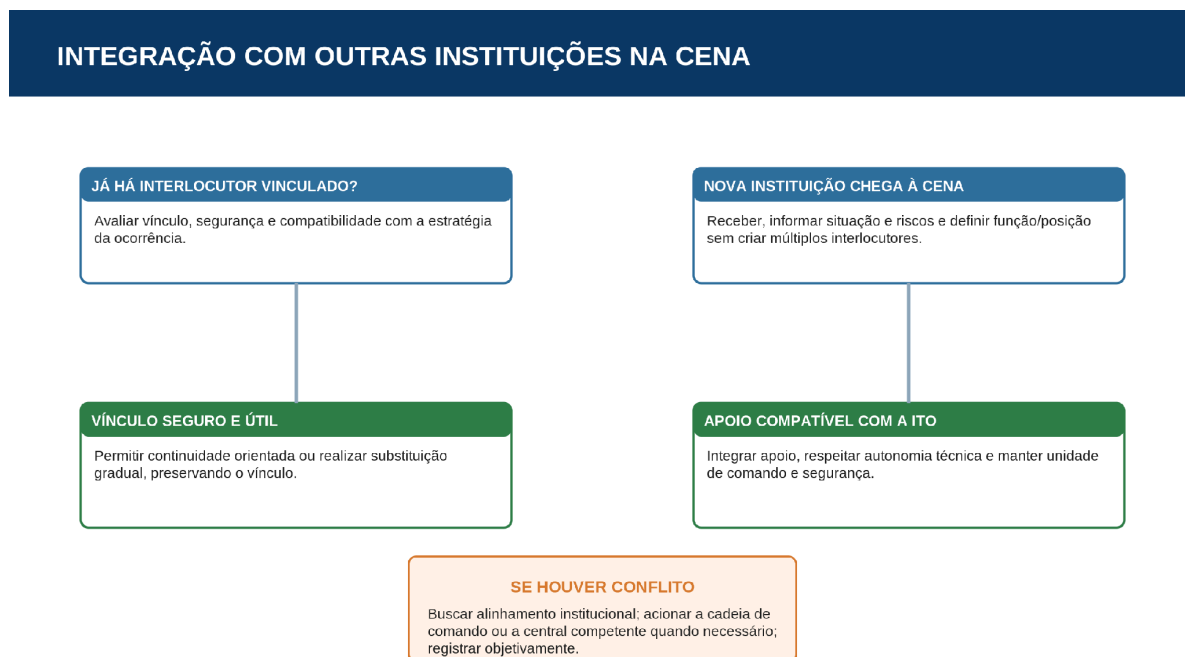
a) se já houver vínculo estabelecido com o tentante, a Gu BM poderá permitir a continuidade da comunicação, desde que a conduta seja segura e compatível com esta ITO;

b) o abordador da Gu BM poderá orientar discretamente o interlocutor, evitando interrupção brusca do vínculo;

c) se não houver vínculo, ou se a comunicação aumentar o risco, deverá ocorrer substituição gradual pelo abordador da Gu BM;

d) a substituição deverá evitar constrangimento, disputa de autoridade e exposição pública do tentante.

Figura 3 — Integração com outras instituições na cena



7.2 Chegada de outras instituições durante a ocorrência

- o comandante da operação deverá receber a instituição que chega à cena, informar situação, riscos, ações em curso, área de isolamento e necessidade de apoio;
- a chegada de novos atores não deverá produzir múltiplos interlocutores com o tentante;
- as instituições presentes deverão ser posicionadas conforme função, segurança e necessidade operacional;
- quando houver divergência de orientação, o comandante da operação deverá buscar alinhamento institucional, acionar o CBU ou a central competente, se houver tempo útil, e registrar o fato de forma objetiva.

7.3 Equipes de saúde, SAMU e rede de urgência

A Gu BM deverá integrar sua atuação com equipes de saúde e SAMU, respeitando competências assistenciais, protocolos próprios e autonomia técnica desses profissionais, sem prejuízo da coordenação da segurança operacional da cena pelo CBMMG.

a) posicione o recurso de saúde de modo a permitir atendimento oportuno após redução do risco, sem aumentar exposição, ruído, tensão ou interferência na abordagem de dissuasão;

b) havendo lesão, intoxicação, alteração de consciência, crise psicótica, agitação intensa ou outro agravo clínico ou traumático, a Gu BM deverá integrar segurança da cena, abordagem de dissuasão e atendimento pré-hospitalar, conforme ITO específica;

c) considere as orientações assistenciais da equipe de saúde, observadas sua competência profissional, a segurança operacional e a estratégia definida para a ocorrência;

d) quando indicada contenção farmacológica, sua execução caberá exclusivamente a profissional de saúde habilitado, conforme competência legal e protocolo próprio;

e) quando houver indicação de contenção farmacológica por profissional habilitado, organize condição de segurança compatível e integração entre comandante da operação, equipe de saúde e demais instituições envolvidas;

7.4 PMMG, Polícia Penal e ocorrência com arma

Em ocorrências com arma de fogo, refém, ameaça armada, risco de violência contra terceiros ou hipótese de homicídio seguido de suicídio, a atuação deverá observar a competência das instituições policiais, cabendo ao CBMMG permanecer em apoio técnico-operacional dentro de suas atribuições.

a) identificada arma de fogo, refém, ameaça armada ou risco policial incompatível com a atuação bombeiro militar, a Gu BM deverá recuar para área segura, buscar anteparo, apoiar o isolamento e acionar ou aguardar a instituição policial competente;

b) em cenas com arma de fogo ou refém, a liderança da dimensão policial da ocorrência caberá à instituição policial competente, permanecendo o CBMMG em apoio nas áreas de salvamento, atendimento pré-hospitalar, prevenção contra incêndio, isolamento técnico, logística e preservação da vida;

c) a abordagem direta pelo CBMMG não deverá ocorrer quando a presença de arma de fogo gerar risco incompatível com os equipamentos, treinamento, atribuições e segurança da guarnição;

d) em ocorrência envolvendo arma branca, objeto perfurocortante, objeto contundente ou ameaça a terceiros, a decisão operacional deverá considerar distância, comportamento, possibilidade de dissuasão, isolamento, anteparo, apoio policial, atendimento pré-hospitalar em pronto emprego e segurança da equipe;

e) qualquer alteração relevante do risco deverá ser comunicada ao comandante da operação, à central competente e às instituições envolvidas.

7.5 Trânsito, concessionárias, energia elétrica, produto perigoso e outros apoios

Os riscos periféricos deverão ser reduzidos por meio do acionamento coordenado de instituições de apoio, conforme natureza da ocorrência, competência legal e necessidade operacional.

a) solicite apoio da PRF, PMRv, órgãos de trânsito ou guardas municipais para isolamento, bloqueio, desvio, controle de fluxo e restrição de acesso, conforme local, risco e necessidade operacional;

b) acione a CEMIG ou concessionária competente quando houver risco elétrico ou necessidade de intervenção técnica na rede;

c) acione concessionárias, Defesa Civil, BEMAD, BOA, equipes de RPA, órgãos ambientais, COPASA ou outros apoios conforme risco identificado, competência e disponibilidade operacional;

d) o emprego de RPA deverá observar ITO específica e somente ocorrer quando contribuir para consciência situacional, segurança operacional ou tomada de decisão, sem aumentar estímulo, exposição ou risco ao tentante;

e) quando houver imprensa, curiosos ou captação indevida de imagens, a Gu BM deverá reforçar isolamento, controle de acesso e orientação para preservação da imagem do tentante, conforme diretrizes desta ITO.

7.6 Condutas gerais e conflitos de orientação

a) o comandante da operação deverá considerar profissionais de outras instituições como potenciais apoiadores, respeitadas as competências próprias, a segurança da cena e a compatibilidade com esta ITO;

b) a Gu BM poderá adotar sugestões técnicas apresentadas por outros profissionais quando forem pertinentes, seguras, compatíveis com as diretrizes do CBMMG e inseridas na coordenação da ocorrência;

c) se houver orientação conflitante capaz de prejudicar a ocorrência, o comandante da operação deverá informar, de forma objetiva e respeitosa, que a ação não será realizada naquele momento;

d) em caso de conflito relevante, o fato deverá ser comunicado ao COBOM/CIAD/SOU/SOF, com solicitação de intervenção do CBU, Comandante de Companhia Operacional ou autoridade equivalente, quando houver tempo útil, devendo a divergência, a interferência externa e a decisão adotada ser registradas de forma objetiva no REDS, RAPH ou relatório próprio.

8 ABORDAGEM DE DISSUAÇÃO

A abordagem de dissuasão deverá ser empregada como primeira linha operacional comunicacional com o tentante, sempre que a segurança da cena permitir. Seu objetivo é reduzir tensão, estabelecer relação comunicacional mínima, compreender os elementos essenciais da crise, identificar fatores de risco e proteção e conduzir o tentante para condição de maior segurança.

A abordagem de dissuasão não se confunde com negociação policial, barganha ou persuasão impositiva. Consiste na condução técnica do diálogo, por meio de escuta, perguntas e ferramentas de diálogo, buscando preservar a dignidade do tentante e favorecer a desistência voluntária.

- a) o abordador deverá manter postura calma, voz baixa e linguagem simples;
- b) a comunicação deverá ser dirigida prioritariamente ao tentante, evitando disputa de fala com terceiros;
- c) a equipe deverá reduzir estímulos desnecessários, curiosos, ruídos, exposição, filmagens e aproximações simultâneas;
- d) o abordador deverá evitar julgamento, ameaça, ironia, desafio, confronto moral, promessas absolutas, frases de minimização ou aconselhamento impositivo;
- e) a abordagem de dissuasão deverá ser reavaliada continuamente pelo comandante da operação, em alinhamento com o abordador, conforme risco, fadiga da equipe, resposta do tentante e sinais verbais ou não verbais de abertura ou fechamento do canal de comunicação.

Conforme Munhoz (2018), há comportamentos gerais desejáveis por parte do abordador durante o atendimento, bem como comportamentos improdutivos que devem ser evitados pela guarnição.

Quadro 8 — Condutas comunicacionais do abordador

Comportamentos desejáveis do abordador	Comportamentos improdutivos a evitar
Entender postura, entonação de voz e gestos do tentante; agir de maneira sincera e atenciosa para fortalecer o vínculo de confiança.	Completar frases para o tentante.

Comportamentos desejáveis do abordador	Comportamentos improdutivos a evitar
Buscar formar vínculo com o tentante.	Mentir, prometer ou seduzir.
Manter canal de comunicação aberto.	Chamar por apelidos ou nomes depreciativos.
Olhar para o tentante em demonstração de atenção, com cautela nos perfis agressivos.	Ser agressivo ou ríspido.
Ouvir atentamente e respeitar pausas silenciosas.	Rir, demonstrar desprezo, ameaçar, desafiar ou julgar.
Repetir, resumir e relacionar ideias para o tentante.	Dar opinião pessoal ou aconselhar de forma impositiva.
Apoiar o tentante a encontrar soluções próprias e dar espaço para perguntas.	Antecipar ação tática sem necessidade, levar parentes ou conhecidos à presença do tentante, comemorar diante dele, ceder a exigências contra o protocolo ou fornecer cigarro, celular, refeição ou similar.

8.1 Aproximação

a) a aproximação deverá ocorrer de forma lenta, progressiva e compatível com a segurança da cena;

b) o abordador deverá manter as mãos visíveis, postura não ameaçadora e distância compatível com os espaços de comunicação;

c) ao ser orientado pelo tentante a parar, ou diante de sinal não verbal de desconforto, o abordador deverá interromper o deslocamento e priorizar a comunicação verbal;

d) antes de avançar, a equipe deverá avaliar riscos ambientais, altura, água, eletricidade, incêndio, trânsito, produtos perigosos, presença de arma, agressor, local confinado, terceiros, multidão, curiosos e possibilidade de fuga ou queda;

e) quando houver risco específico, o comandante da operação deverá acionar recurso adequado ou aplicar a ITO correspondente;

f) a aproximação somente deverá prosseguir quando houver avaliação favorável de segurança e abertura mínima à comunicação.

8.2 Silêncio inicial

a) o silêncio inicial poderá ser utilizado por breve período, como intervalo observacional, apenas para leitura da cena, redução de pressão e adaptação do tentante à presença do abordador;

b) o silêncio inicial não deverá ser prolongado a ponto de gerar percepção de abandono, insegurança, constrangimento ou perda de oportunidade de vínculo;

c) durante esse breve intervalo, o abordador deverá observar postura, olhar, respiração, movimentos, reação à aproximação, resposta à presença da equipe e sinais de abertura ou fechamento comunicacional;

d) encerrado o intervalo observacional, o abordador deverá iniciar ou retomar a comunicação de forma calma, breve e compatível com a resposta do tentante.

8.3 Apresentação pessoal

a) a apresentação pessoal deverá ser simples, breve, sem pressa e sem excesso de formalidade;

b) após o silêncio inicial, o abordador deverá apresentar-se ao tentante dizendo seu nome, sua função e que está ali para ouvi-lo. Por exemplo: “Oi, meu nome é Thaís, sou bombeira militar, e estou aqui para te ouvir!”;

c) o abordador deverá evitar saudações automáticas como “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite” ou “como vai você?”, quando puderem soar inadequadas diante da crise;

d) o abordador não deverá dizer que está ali para ajudá-lo, pois o tentante poderá solicitar algo que não possa ser realizado, com risco de quebra de confiança;

e) se o tentante estiver em ambiente domiciliar ou local fechado, antes de entrar o abordador deverá pedir licença em voz alta, de modo simples e audível, preservando respeito, segurança e previsibilidade, sem avançar caso a entrada aumente o risco;

f) a entrada em ambiente fechado somente deverá ocorrer após avaliação favorável de segurança, controle mínimo da cena e definição do comandante da operação;

g) a apresentação não deverá conter promessas absolutas, sermões, ameaças, perguntas invasivas ou tentativa imediata de convencimento.

8.4 Perguntas simples

As perguntas simples deverão ser utilizadas para abrir comunicação, reduzir tensão, verificar segurança imediata e rastrear, de forma breve e operacional, fatores de risco predisponentes, fatores de risco precipitantes e fatores de proteção, obtendo informações úteis para a continuidade da abordagem e para o uso das ferramentas de diálogo.

a) o abordador deverá formular uma pergunta por vez;

b) as perguntas deverão ser curtas, concretas e compatíveis com o nível de resposta do tentante;

c) as perguntas deverão priorizar segurança imediata, abertura comunicacional, identificação de pessoas de confiança, fatores de risco e fatores de proteção;

d) o abordador deverá evitar sequência de perguntas em ritmo de interrogatório, perguntas invasivas ou exigência de justificativas;

e) se houver silêncio, confusão, agitação ou baixa responsividade, a pergunta deverá ser simplificada ou substituída por fala breve de acolhimento e presença;

f) as respostas obtidas deverão ser repassadas ao comandante da operação, quando relevantes para avaliação de risco, segurança da cena, preparação tática ou encaminhamento.

Quadro 9 — Perguntas simples

Finalidade	Exemplos operacionais	Cuidados
Abrir comunicação	“Posso conversar com você?”; “Como você prefere que eu te chame?”	Evitar pressão ou tom de interrogatório.
Reduzir tensão	“Você consegue me ouvir daqui?”; “Está melhor eu ficar aqui ou um pouco mais afastado?”	Manter voz calma e ritmo lento.
Identificar apoio	“Tem alguém de confiança que você aceita que a gente chame?”	Não aproximar terceiros sem avaliar risco.
Avaliar necessidade imediata	“Você está sentindo dor?”; “Precisa de atendimento agora?”	Acionar atendimento pré-hospitalar e, quando necessário, acionamento do SAMU ou da rede de saúde conforme risco clínico.

8.5 Perguntas complexas

As perguntas complexas deverão ser utilizadas após vínculo mínimo, quando o tentante demonstrar capacidade de diálogo, a cena estiver sob controle suficiente e houver abertura para maior elaboração da fala.

- a) as perguntas deverão contribuir para que o tentante organize sofrimento, fator precipitante, ambivalência, fatores de proteção e próximo passo seguro;
- b) o abordador deverá formular perguntas com calma, uma de cada vez, evitando linguagem longa, abstrata ou de difícil compreensão;
- c) o abordador deverá evitar perguntas que aumentem culpa, vergonha, desafio, sensação de julgamento ou necessidade de justificar a crise;

d) a pergunta complexa deverá ser interrompida ou simplificada se aumentar agitação, confusão, irritação, silêncio defensivo ou risco;

e) o objetivo não é realizar entrevista clínica, investigação profunda ou aconselhamento, mas favorecer segurança, vínculo, microdecisões seguras e continuidade do cuidado.

Quadro 10 — Perguntas complexas

Finalidade	Formulação possível	Limite
Compreender sofrimento	“O que aconteceu hoje que deixou tudo mais difícil?”	Não exigir relato detalhado.
Explorar ambivalência	“Tem uma parte sua que ainda aceita conversar comigo?”	Não discutir se a dor é real.
Identificar proteção	“Quem ou o que ainda importa para você neste momento?”	Evitar manipulação emocional.
Construir próximo passo	“Qual é o menor passo seguro que você consegue fazer agora?”	Não oferecer opção de risco.

8.6 Ferramentas de diálogo

As ferramentas de diálogo deverão auxiliar o abordador a manter vínculo, reduzir tensão, organizar minimamente a fala do tentante e conduzi-lo para microações seguras. O abordador deverá evitar deslocar a conversa para si, dar conselhos impositivos ou impor solução pronta; sua conduta deverá favorecer que o tentante reconheça alternativas próprias de segurança e cuidado.

a) fatores de risco predisponentes não deverão ser utilizados como foco principal de diálogo direto com o tentante, pois podem ampliar culpa, vergonha, estigma ou

desesperança, devendo ser acolhidos com cautela quando surgirem espontaneamente na fala;

b) fatores de risco precipitantes poderão ser utilizados com cautela, tanto em perguntas complexas quanto na técnica do sucesso anterior, para organizar a crise, identificar situações parecidas já enfrentadas e recursos mobilizados;

c) fatores de proteção poderão ser utilizados na ponte para o futuro e na ponte para o passado, desde que não sejam empregados como pressão, chantagem emocional ou cobrança de responsabilidade;

d) os fatores de risco e de proteção utilizados nas ferramentas de diálogo deverão decorrer, preferencialmente, das informações coletadas nas perguntas simples, da observação da cena e das falas espontâneas do tentante, sem investigação invasiva ou ritmo de interrogatório.

8.6.1 Técnica do sucesso anterior

Use a técnica do sucesso anterior para identificar recursos previamente mobilizados pelo tentante em situações difíceis, quando houver vínculo mínimo e a recordação não ampliar o sofrimento. Evite comparação de dores ou cobrança de desempenho. Consulte o Apêndice B para aplicação operacional.

8.6.2 Ponte para o futuro

Use a ponte para o futuro para favorecer referência concreta a atividade, compromisso, pessoa ou rotina futura significativa, quando houver abertura ao diálogo. Evite promessas, garantias ou argumentos abstratos. Consulte o Apêndice C.

8.6.3 Ponte para o passado

Use a ponte para o passado para acessar lembrança segura e significativa que favoreça organização do diálogo, quando houver vínculo e a evocação não aumentar o sofrimento. Interrompa ou redirecione se houver piora perceptível. Consulte o Apêndice D.

8.6.4 Paráfrase resumida

Use a paráfrase resumida para demonstrar escuta e organizar, com palavras breves, o conteúdo principal apresentado pelo tentante. Não interprete, diagnostique ou acrescente conclusões não verbalizadas. Consulte o Apêndice E.

8.6.5 Evitar frases de negação

Prefira comandos positivos, concretos e executáveis quando a formulação negativa puder aumentar tensão ou ambiguidade. Em situação de perigo imediato, priorize clareza e segurança. Consulte o Apêndice F.

8.6.6 Confrontação empática

Use a confrontação empática para reconhecer o sofrimento e, simultaneamente, sustentar limite protetivo claro, sem validar o comportamento de risco como solução. Evite sermão, culpa, ameaça ou promessa absoluta. Consulte o Apêndice G.

8.6.7 Microdecisão segura

Use a microdecisão segura para convidar o tentante a realizar pequena escolha imediata que favoreça segurança ou continuidade do diálogo, quando houver abertura suficiente e a escolha não aumentar o risco. Consulte o Apêndice H.

8.7 Perfis comportamentais na tentativa de suicídio

Os perfis comportamentais descritos possuem finalidade operacional e não substituem avaliação clínica ou diagnóstico. O tentante poderá alternar comportamentos durante a ocorrência, devendo a guarnição adaptar comunicação e segurança conforme a resposta observada.

8.7.1 Perfil agressivo

Diante de comportamento hostil, ameaçador ou intensamente irritável, priorize distância segura, tom estável, limites claros e redução de estímulos. Não transforme a observação em diagnóstico. Consulte o Apêndice I.

8.7.2 Perfil depressivo

Diante de retraimento, lentificação, choro, culpa, desesperança ou baixa responsividade, reduza o ritmo da comunicação, utilize perguntas simples e preserve pausas. Não confunda baixa expressão com baixo risco. Consulte o Apêndice I.

8.7.3 Perfil psicótico

Diante de fala desorganizada, medo intenso, percepção alterada ou crenças fixas, utilize linguagem simples, reduza estímulos, não confronte diretamente a experiência percebida e reavalie continuamente a segurança. Consulte o Apêndice I.

8.8 Dinâmicas na abordagem

A abordagem deverá ser conduzida de forma dinâmica, com avaliação contínua do vínculo, da fadiga, do risco e da necessidade de reorganização da equipe.

8.8.1 Troca do abordador

a) a troca do abordador poderá ocorrer por fadiga, perda de vínculo, rejeição do tentante ao abordador, hostilidade direcionada, dificuldade de comunicação ou decisão do comandante da operação;

b) a troca deverá ser gradual, quando possível, com transição verbal breve e sem ruptura brusca do vínculo;

c) o novo abordador deverá receber informações sobre temas sensíveis, fatores de proteção, ferramentas já utilizadas, respostas do tentante e sinais recentes de abertura ou fechamento comunicacional.

8.8.2 Uso do abordador auxiliar

a) o abordador auxiliar deverá apoiar a coleta de informações, observar riscos, monitorar sinais não verbais, identificar fadiga do abordador e auxiliar o comandante da operação;

b) o abordador auxiliar não deverá competir verbalmente com o abordador nem criar dupla condução da comunicação;

c) poderá assumir a abordagem quando houver orientação do comandante da operação ou necessidade técnica.

8.8.3 Fadiga da equipe

a) o comandante da operação deverá monitorar sinais de fadiga, irritabilidade, impaciência, perda de foco ou redução da qualidade comunicacional da equipe;

b) a fadiga deverá ser compreendida como fator operacional de risco, podendo justificar revezamento, pausa operacional segura ou substituição do abordador;

c) após ocorrência crítica, deverá ser avaliada necessidade de cuidado com a equipe, conforme item de posvenção e Primeiros Socorros Psicológicos.

8.8.4 Saída honrosa

- a) a saída honrosa consiste na condução do tentante para local seguro, preservando sua dignidade, privacidade e sensação mínima de controle da situação;
- b) o abordador deverá evitar expressões que indiquem derrota, vergonha, culpa, exposição pública, espetáculo ou rendição;
- c) a equipe deverá reduzir curiosos, afastar registros de imagem e orientar movimentação discreta, sempre que a segurança permitir;
- e) a saída do ponto de risco deverá ser apresentada como continuidade do cuidado, e não como punição, constrangimento ou fracasso.

8.8.5 Transição da abordagem de dissuasão para a abordagem tática

A transição da abordagem de dissuasão para a abordagem tática deverá ocorrer de forma planejada, discreta e coordenada, quando houver sinais claros de agravamento imediato do risco e a intervenção física se mostrar necessária para preservação da vida.

- a) a transição para a abordagem tática deverá ser considerada quando houver sinais claros de suicídio iminente, fechamento abrupto do canal de diálogo, aumento imediato do risco ou progressão para o ponto crítico;
- b) a abordagem tática não deverá ser adotada apenas por demora, silêncio, baixa responsividade, frustração da equipe, dificuldade de vínculo ou ausência de resultado imediato da abordagem de dissuasão;
- c) a decisão deverá ser do comandante da operação, com base na segurança da cena, no comportamento do tentante, no risco à equipe e a terceiros, na oportunidade tática segura, nos recursos disponíveis e nas informações repassadas pelo abordador;
- d) identificados sinais de agravamento, o abordador deverá manter a comunicação, quando possível, sem alertar o tentante sobre eventual intervenção, enquanto o comandante da operação organiza discretamente a equipe tática;
- e) as informações obtidas pelo abordador deverão subsidiar a equipe responsável pela abordagem tática, especialmente quanto a comportamento, resposta ao diálogo, limites de aproximação, riscos da cena, fatores de proteção e oportunidade segura;

f) são sinais de canal aberto para manutenção da abordagem de dissuasão: responder com gestos ou palavras, dirigir atenção ao abordador, reduzir a velocidade dos movimentos, interromper progressão para o risco, permitir aproximação gradual, demonstrar dúvida ou ambivalência, manter distância estável do ponto crítico ou aceitar pequenas solicitações de segurança;

g) são sinais de alerta para preparação da abordagem tática: redução progressiva das respostas, aumento de agitação, recusa persistente de microações seguras, aproximação gradual do ponto crítico, perda de atenção ao abordador, oscilação rápida do comportamento ou manipulação de meio de risco;

h) são sinais de possível fechamento abrupto do canal de diálogo: interrupção súbita das respostas, despedida, recusa total de comunicação após período de vínculo, redução abrupta da distância crítica, movimento decidido em direção ao ponto de risco ou comportamento incompatível com a continuidade segura da abordagem de dissuasão;

i) a intervenção tática somente deverá ocorrer mediante decisão do comandante da operação, oportunidade segura, equipe posicionada, comunicação interna definida e manutenção da prioridade absoluta de preservação da vida;

A decisão operacional deverá observar também a matriz consolidada apresentada na Figura 4.

9 ABORDAGEM INCLUSIVA E COMUNICAÇÃO ADAPTADA

A abordagem inclusiva deverá orientar adaptações necessárias, proporcionais e seguras da comunicação, da aproximação e do acionamento de rede diante de públicos com necessidades específicas, sem alterar a prioridade da ocorrência: preservar a vida, reduzir risco, proteger a cena e encaminhar adequadamente.

9.1 Diretrizes gerais de abordagem inclusiva

a) o abordador deverá considerar, quando relevante à comunicação e à segurança da ocorrência, idade, deficiência, neurodivergência, necessidades de acessibilidade e condição de saúde aparente;

b) também deverão ser considerados, quando relevantes, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raça/cor, religião, condição social, contexto familiar, violência doméstica ou outra situação de vulnerabilidade;

c) a adaptação da abordagem deverá priorizar comunicação simples, redução de estímulos, privacidade, respeito e segurança;

d) não se deve infantilizar, ridicularizar, expor, pressupor identidade, julgar crenças, fazer comentários sobre corpo, aparência, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero;

e) deverá ser utilizado nome social ou forma de tratamento indicada pelo tentante, quando informado e quando isso não comprometer a segurança da cena;

f) a presença de familiar, cuidador, pessoa de confiança ou terceiro não é regra e somente deverá ser admitida se houver avaliação favorável de segurança, vínculo e utilidade técnica;

g) familiares, cuidadores ou pessoas de confiança não deverão ser conduzidos automaticamente à cena, devendo sua participação ser excepcional, técnica e autorizada pelo comandante da operação.

9.2 Comunicação adaptada

a) utilizar frases curtas, concretas e compatíveis com a resposta do tentante;

b) falar uma pessoa por vez, evitando sobreposição de vozes ou comandos;

- c) aguardar tempo maior de resposta quando necessário, sem pressionar ou repetir perguntas de forma excessiva;
- d) utilizar recursos escritos, visuais ou apoio técnico quando forem seguros, úteis e compatíveis com a cena;
- e) confirmar compreensão por meio de checagem breve, reformulação simples ou pergunta de confirmação.

9.3 Crianças e adolescentes

- a) a abordagem de crianças e adolescentes deverá utilizar linguagem simples, concreta, respeitosa e compatível com a idade, evitando tom infantilizado, bronca, ameaça, culpabilização, exposição pública ou interpretação da crise como drama, manipulação, fase ou chamado de atenção;
- b) a equipe deverá considerar, quando relevante à segurança e à comunicação, a influência de pares, família, escola, redes sociais, violência, bullying, ruptura afetiva, sofrimento emocional ou sofrimento psíquico;
- c) a presença de pais, responsáveis, professores, colegas ou terceiros somente deverá ser admitida quando houver avaliação favorável de segurança, vínculo, utilidade técnica e ausência de aumento do risco;
- d) em ocorrências envolvendo criança ou adolescente, deverá ser avaliado o acionamento do Conselho Tutelar, rede de proteção, escola, serviço de saúde ou assistência social, conforme o caso e o fluxo local;
- e) o abordador poderá utilizar, com respeito e sem ironia, elementos observáveis de interesse da criança ou do adolescente, como time, personagem, música, desenho, acessório ou objeto pessoal, para iniciar ou sustentar o vínculo;
- f) a comunicação deverá preservar privacidade, dignidade e previsibilidade, evitando disputa de autoridade, exposição diante de colegas, responsabilização moral ou pressão para relato detalhado da crise.

9.4 Pessoas idosas

- a) em ocorrências envolvendo pessoas idosas, a guarnição deverá considerar isolamento, luto, doença crônica, dor, dependência funcional, abandono, violência

patrimonial, violência familiar, alteração cognitiva, confusão, uso de medicamentos e fragilidade clínica como fatores relevantes à segurança e ao encaminhamento;

b) a comunicação deverá ser simples, respeitosa e objetiva, sem infantilização, impaciência, exposição indevida ou pressuposição de incapacidade;

c) familiar, cuidador, vizinho ou pessoa de confiança poderá ser ouvido fora da área de risco e somente deverá aproximar-se do tentante quando houver avaliação favorável de segurança, vínculo e utilidade técnica, devendo a guarnição considerar se constitui vínculo efetivamente protetivo ou se há indícios de negligência, violência, abandono ou interferência negativa;

d) quando necessário, deverão ser acionados serviço de saúde, assistência social, rede de proteção, SAMU ou outro órgão competente, conforme risco clínico, vulnerabilidade e fluxo local.

9.5 Pessoas com deficiência

a) em ocorrências envolvendo pessoa com deficiência, a guarnição deverá identificar barreiras de comunicação, mobilidade, compreensão, sensibilidade sensorial ou dependência de cuidador, sem pressupor incapacidade decisória ou infantilizar o tentante;

b) deverão ser utilizados recursos de acessibilidade, comunicação escrita, visual, Libras, apoio de cuidador ou profissional de referência quando forem seguros, úteis e compatíveis com a cena;

c) a aproximação, o isolamento e o encaminhamento deverão preservar autonomia, dignidade, privacidade e segurança, observadas as necessidades específicas da pessoa.

9.6 Tentantes neurodivergentes

a) a guarnição deverá considerar indícios ou informações sobre autismo, Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade — TDAH, deficiência intelectual ou outra condição que interfira na comunicação, previsibilidade ou resposta à abordagem;

b) a guarnição não deverá realizar diagnóstico, devendo adaptar a abordagem diante de informação confiável, relato de terceiros ou sinais observáveis de dificuldade comunicacional, desconforto sensorial ou reação intensa a mudanças e estímulos;

- c) o abordador deverá utilizar linguagem concreta, objetiva e previsível, com frases curtas, uma orientação por vez e sem metáforas complexas;
- d) sempre que possível, deverão ser reduzidos ruídos, luzes intensas, movimentos bruscos, aproximações simultâneas, toque não anunciado, sobreposição de vozes e presença de pessoas sem função operacional;
- e) o tempo de resposta do tentante deverá ser respeitado, evitando pressão, interrupções, exigência de contato visual, múltiplas perguntas ou comandos simultâneos;
- f) poderá ser considerado apoio de familiar, cuidador, profissional de referência ou pessoa de confiança somente quando houver avaliação favorável de segurança, vínculo, utilidade técnica e ausência de constrangimento ao tentante;
- g) não deverá ser admitida a presença de familiar ou terceiro que aumente o risco, interfira negativamente no vínculo, pressione o tentante ou contrarie a estratégia do comandante da operação;
- h) quando possível, o comandante da operação deverá colher informações com familiares, cuidadores ou profissionais de referência fora da área de risco, preservando a cena e o vínculo do abordador.

9.7 Mulheres e meninas em sua diversidade

- a) em ocorrências envolvendo mulheres, a guarnição deverá observar possíveis indícios de violência, controle, ameaça, medo, silenciamento ou presença de pessoa que interfira negativamente na fala;
- b) a comunicação deverá evitar julgamento moral, estereótipos, culpabilização ou deslegitimação do relato;
- c) a tentante deverá ser tratada pelo nome informado, inclusive nome social, quando declarado;
- d) deverão ser evitados questionamentos sobre corpo, vida íntima, identidade de gênero ou orientação sexual, salvo quando estritamente necessários à segurança ou ao encaminhamento;
- e) não deverão ser expostos nome social, identidade de gênero, orientação sexual ou condição pessoal da tentante a familiares, curiosos, imprensa ou terceiros;

f) deverá ser considerado risco de violência, discriminação, expulsão familiar, humilhação pública ou ameaça motivada por orientação sexual, identidade de gênero ou outra condição de vulnerabilidade;

g) quando houver suspeita de violência, a guarnição deverá proteger a tentante, preservar a cena e os vestígios, sem manipulação indevida, e acionar a rede competente.

9.8 Tentante em contexto de violência doméstica

a) quando houver suspeita de violência doméstica associada à tentativa de suicídio, a guarnição deverá considerar esse contexto como possível fator de risco precipitante e elemento de interferência na abordagem, avaliando simultaneamente o risco de comportamento autoinfligido e o risco de violência proveniente do possível agressor ou de terceiros;

b) a guarnição deverá avaliar, antes da aproximação e durante toda a ocorrência, a presença, proximidade, influência ou controle exercido por possível agressor;

c) o possível agressor não deverá conduzir a comunicação com a pessoa tentante, ser tratado como principal fonte de informação da ocorrência ou acompanhar a condução quando representar risco;

d) avaliada a segurança no cenário, deverá ser preservada separação física e comunicacional entre a pessoa tentante e o possível agressor, evitando confronto direto entre ambos na cena;

e) a pessoa tentante não deverá ser pressionada a relatar detalhes da violência durante a abordagem;

f) se houver risco à pessoa tentante, à equipe ou a terceiros, deverá ser solicitado apoio policial;

g) quando houver criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência em risco, deverá ser avaliado acionamento da rede competente;

h) o registro deverá ser objetivo, sem juízo de valor, preservando informações relevantes para segurança, proteção, encaminhamento e continuidade do cuidado.

10 ABORDAGEM TÁTICA

A abordagem tática é a linha operacional excepcional do Sistema ATTS destinada à intervenção física, rápida, segura e proporcional, quando houver alteração objetiva do risco que exija ação imediata, risco grave à segurança ou oportunidade tática segura para preservação da vida. Seu emprego não depende obrigatoriamente do encerramento da comunicação.

Seu emprego não substitui a abordagem de dissuasão. A comunicação deverá ser mantida enquanto for segura e útil, mesmo durante a preparação tática, preservando o vínculo, reduzindo estímulos e evitando movimentos que antecipem a intervenção sem necessidade operacional.

A abordagem tática deverá ser decidida pelo comandante da operação, em alinhamento com o abordador e com a equipe técnica disponível, observando segurança da cena, recursos presentes, possibilidade de dano ao tentante, risco à equipe, risco a terceiros e limites operacionais do CBMMG.

10.1 Princípios de emprego

a) empregue a abordagem tática como recurso excepcional, quando a avaliação objetiva do risco indicar necessidade de intervenção física imediata ou oportunidade tática segura para preservação da vida;

b) preparar a equipe tática de forma discreta, sem produzir intimidação, quebra de vínculo ou aumento desnecessário da tensão na cena;

c) definir, no início da ocorrência e quando houver possibilidade de emprego tático, sinal, palavra-senha ou comunicação interna para acionamento, compatíveis com ruído, distância e dinâmica do local;

d) manter unidade de comando, clareza de funções, rotas de retirada, comunicação entre comandante, abordador, abordador auxiliar e equipe tática;

e) utilizar EPI, equipamentos, ancoragens, sistemas de proteção, viaturas, anteparos e recursos especializados compatíveis com o risco identificado;

f) evitar improvisação, aproximação simultânea de várias equipes, movimentos abruptos ou ação física sem avaliação da oportunidade tática;

g) preservar, sempre que possível, a comunicação do abordador até o momento da intervenção, sem anunciar a ação tática ao tentante;

h) aplicar o menor nível de força necessário, pelo menor tempo possível, com foco exclusivo na preservação da vida e na segurança da cena;

i) após a intervenção, providenciar avaliação de segurança, atendimento pré-hospitalar, saída honrosa, condução à unidade de urgência e registro objetivo da decisão e da conduta adotada.

10.2 Critérios de transição para abordagem tática

A transição deverá ser considerada quando houver agravamento imediato do risco, fechamento abrupto do canal de comunicação, gesto preparatório, movimento em direção ao ponto crítico, risco grave à equipe ou a terceiros, ou oportunidade tática segura que permita intervenção proporcional e orientada à preservação da vida.

Figura 4 — Matriz de decisão entre abordagem de dissuasão e abordagem tática

MATRIZ DE DECISÃO — DISSUAÇÃO E ABORDAGEM TÁTICA

MANTER DISSUAÇÃO	PREPARAR ABORDAGEM TÁTICA	ACIONAR ABORDAGEM TÁTICA
- Canal de comunicação preservado. - Respostas verbais ou gestuais. - Atenção dirigida ao abordador. - Estabilidade suficiente para continuidade segura. - Aceitação de pequenas orientações de segurança.	- Redução progressiva das respostas. - Oscilação rápida do comportamento. - Progressão do risco ou perda de estabilidade. - Manipulação de elemento de risco. - Necessidade de posicionar equipe e recursos.	- Risco iminente ou mudança abrupta da cena. - Fechamento súbito do canal com agravamento. - Gesto ou movimento incompatível com espera segura. - Risco grave à equipe ou a terceiros. - Oportunidade segura para intervenção proporcional.

A decisão é do comandante da operação e considera segurança, oportunidade, recursos disponíveis e informações da equipe.

10.3 Preparação da equipe tática

a) a equipe tática deverá ser composta, preferencialmente, por bombeiros militares com capacitação compatível com o risco presente e com os recursos disponíveis;

b) o comandante da operação deverá definir função de cada integrante, rota de aproximação, rota de retirada, ponto de segurança, sinal de acionamento e local de atendimento após a retirada do ponto de risco;

c) o abordador deverá repassar ao comandante da operação informações relevantes sobre vínculo, fatores de risco, fatores de proteção, temas sensíveis, sinais de abertura ou fechamento comunicacional e microações já aceitas;

d) a equipe deverá conferir EPI, comunicação, iluminação, sistemas de proteção, recursos de salvamento, APH/SAMU e apoio policial ou técnico, conforme o risco identificado e a doutrina específica aplicável;

e) a abordagem tática deverá permanecer pronta para emprego quando indicada, sem exposição desnecessária ao tentante e sem prejudicar a abordagem de dissuasão;

f) o acionamento tático deverá ocorrer por ordem do comandante da operação, salvo situação absolutamente imediata de preservação da vida em que não haja tempo útil para nova deliberação.

10.4 Emprego conforme risco específico

Os itens seguintes indicam condutas gerais para riscos recorrentes em ocorrências de ATTS. A guarnição deverá observar a ITO, MABOM ou protocolo específico aplicável ao cenário, mantendo a coordenação do comandante da operação, a segurança da cena, a abordagem de dissuasão enquanto viável e o acionamento de recursos especializados quando necessário.

10.4.1 Risco de precipitação ou ambiente vertical

Considere que vínculo comunicacional preservado não significa risco físico controlado; reavalie continuamente a posição, o ambiente e a possibilidade de progressão ao ponto crítico, mantendo recursos de proteção compatíveis preparados quando aplicável.

a) observar a doutrina de salvamento em altura vigente e estabelecer condição segura para acesso, aproximação e eventual intervenção;

b) avaliar bordas, estruturas, vento, iluminação, rotas de acesso e retirada, sistemas de proteção e demais riscos do ambiente;

c) empregar equipe, EPI e equipamentos compatíveis com o cenário, evitando improvisações e aproximação sem avaliação técnica favorável;

d) manter a abordagem de dissuasão enquanto for segura e útil, integrando-a à preparação dos recursos de salvamento.

10.4.2 Risco aquático

a) observar a doutrina de salvamento aquático vigente e priorizar recursos e técnicas compatíveis com o ambiente;

b) avaliar condições da água, margens, acesso, visibilidade, obstáculos, exposição da equipe e rota de retirada;

c) empregar equipe e equipamentos de proteção e salvamento adequados, mantendo atendimento pré-hospitalar em condição de pronto emprego;

d) preservar a abordagem de dissuasão quando possível, sem aumentar a exposição da equipe ou do tentante.

10.4.3 Risco de incêndio, explosão, fumaça ou atmosfera perigosa

a) observar as doutrinas de combate a incêndio, produtos perigosos e atendimento pré-hospitalar aplicáveis ao cenário;

b) avaliar fonte de risco, ventilação, fumaça, calor, possibilidade de explosão ou colapso, direção do vento e necessidade de isolamento;

c) estabelecer EPI/EPR, recursos de proteção, combate e retirada antes da aproximação, conforme a avaliação técnica;

d) não realizar intervenção em área insegura sem controle mínimo dos riscos e recursos compatíveis.

10.4.4 Risco elétrico

a) acionar a concessionária competente quando houver instalação, estrutura ou rede elétrica que possa comprometer a segurança da ocorrência;

b) observar as zonas de risco previstas na ITO específica e impedir acesso de pessoal ou equipamentos à área insegura;

c) somente permitir aproximação técnica após confirmação das condições de segurança pela equipe competente;

d) manter atendimento pré-hospitalar em condição de pronto emprego diante da possibilidade de agravo clínico ou queda.

10.4.5 Risco de enforcamento

a) avaliar imediatamente a segurança da cena, a possibilidade de comunicação, a necessidade de acesso especializado e a disponibilidade de atendimento pré-hospitalar;

b) manter a abordagem de dissuasão enquanto houver comunicação possível e segura, preparando discretamente os recursos necessários à preservação da vida;

c) eventual intervenção deverá ocorrer somente diante de necessidade imediata, oportunidade segura e condições técnicas compatíveis, sob coordenação do comandante da operação;

d) após o acesso, aplicar atendimento pré-hospitalar conforme ITO específica e preservar o local quando houver necessidade legal ou pericial.

10.4.6 Arma branca, objeto perfurocortante ou objeto de risco

a) acionar apoio policial quando houver ameaça a terceiros ou risco de agressão incompatível com a segurança da guarnição;

b) estabelecer distância, anteparo, rota de retirada e controle de acesso antes de qualquer aproximação;

c) manter o abordador em posição protegida e evitar contato físico enquanto o risco à equipe for inaceitável;

d) integrar dissuasão, apoio policial e atendimento pré-hospitalar conforme a evolução do risco e os limites operacionais do CBMMG.

10.4.7 Intoxicação exógena, ambiente fechado ou local trancado

a) avaliar comunicabilidade, condição aparente do tentante, ventilação, segurança do ambiente e necessidade de acesso para prestação de socorro;

b) diante de ausência de resposta ou agravamento, o comandante da operação deverá avaliar acesso natural ou entrada forçada conforme o item 10.1 desta ITO e a doutrina específica aplicável;

c) antes do acesso, identificar riscos ambientais, estruturais, de incêndio, produto perigoso, agressão e demais condições que exijam recurso especializado;

d) após o acesso, aplicar atendimento pré-hospitalar conforme ITO específica e manter avaliação do risco até transferência segura do cuidado.

10.4.8 Arma de fogo, refém ou risco de natureza policial

a) ocorrência com arma de fogo, refém, ameaça armada ou risco de homicídio-suicídio deverá ter liderança operacional policial, cabendo ao CBMMG atuar em apoio dentro de suas competências;

b) a Gu BM deverá recuar para área segura, estabelecer ou apoiar isolamento, manter anteparo e aguardar equipe policial competente;

c) o CBMMG poderá prestar apoio técnico-operacional em APH, salvamento, incêndio, isolamento, logística e orientação comunicacional, quando solicitado e seguro;

d) a abordagem direta pelo CBMMG não deverá ocorrer quando a presença de arma de fogo gerar risco incompatível com os equipamentos e atribuições da guarnição;

e) qualquer mudança de risco deverá ser comunicada ao comandante da operação, à central e às instituições envolvidas.

Quadro 20 — Síntese de riscos específicos e apoios correlatos

Risco específico	Conduta prioritária	Apoio/ITO correlata
Precipitação ou altura	dissuasão, salvamento em altura, ancoragem segura, delimitadores quando indicados	MABOM/ITO de salvamento em altura

Risco específico	Conduta prioritária	Apoio/ITO correlata
Ambiente aquático	menor exposição da equipe, recurso flutuante, salvamento aquático e APH	MABOM Salvamento Aquático / ITO 23
Incêndio, explosão ou fumaça	EPI/EPR, rota de fuga, linha de proteção e recursos de incêndio	MABOM Incêndio / ITO Produtos Perigosos
Eletricidade	acionar concessionária, respeitar zonas de risco e desenergização confirmada	ITO 31 / concessionária
Arma branca ou objeto de risco	anteparo, distância, apoio policial e APH pronto emprego	PMMG / ITO 23
Arma de fogo ou refém	liderança policial e apoio BM em área segura	PMMG/PCMG / APH / Salvamento

10.5 Fluxos de apoio à decisão

Utilize o Apêndice A para visão geral do Sistema ATTS e a Figura 4 para apoio à decisão entre manutenção da dissuasão, preparação e acionamento da abordagem tática. Esses instrumentos não substituem a avaliação contínua do comandante da operação.

10.6 Condutas após a abordagem tática

a) cessado o risco imediato, a equipe deverá estabilizar a cena, preservar a segurança, controlar a exposição pública do tentante e impedir novas fontes de risco;

b) o tentante deverá receber avaliação pré-hospitalar conforme ITO específica, observando lesões, alteração de consciência, intoxicação, agitação, dor, respiração, circulação e necessidade de recurso assistencial adicional;

c) o abordador poderá acompanhar a transição após a intervenção quando isso favorecer segurança, adesão ao atendimento e continuidade do vínculo, desde que haja disponibilidade operacional e decisão do comandante da operação;

d) o registro deverá indicar, de forma objetiva, o risco observado, o motivo da transição para a abordagem tática, o sinal de acionamento quando pertinente, a conduta adotada, os recursos empregados e o desfecho operacional;

e) quando houver lesão grave, óbito presumido ou indícios de crime, deverão ser observadas as diretrizes de preservação de local, cadeia de custódia e acionamento da autoridade competente.

11 ENTRADA NO AMBIENTE E CONTENÇÃO

A entrada no ambiente poderá ocorrer por acesso natural ou por entrada forçada, observadas a segurança da cena, a avaliação de risco, a possibilidade de comunicação com o tentante e a necessidade de prestação de socorro.

A entrada forçada constitui medida excepcional e deverá ser precedida, sempre que possível, de tentativa de comunicação, avaliação do comandante da operação, definição de funções, controle dos riscos do ambiente e preparação para atendimento pré-hospitalar imediato.

11.1 Entrada no ambiente e entrada forçada

a) priorizar acesso voluntário e manutenção da comunicação sempre que a segurança e a urgência permitirem;

b) antes de entrada forçada, verificar acessos disponíveis, necessidade efetiva de ingresso, riscos do ambiente e hipótese legal aplicável;

c) a entrada forçada somente deverá ocorrer quando houver necessidade concreta de prestação de socorro ou risco à vida incompatível com a espera, mediante decisão do comandante da operação;

d) o comandante deverá definir funções, rota de acesso e retirada, EPI, recursos de salvamento e atendimento pré-hospitalar antes do ingresso, sempre que houver tempo útil;

e) deverão ser avaliados riscos estruturais, incêndio, atmosfera perigosa, eletricidade, agressor, arma, animais, queda e demais condições que exijam apoio especializado;

f) após o acesso, a equipe deverá controlar o ambiente e integrar segurança, abordagem de dissuasão, atendimento pré-hospitalar e contenção, quando esta for indispensável;

g) danos ao ambiente deverão limitar-se ao necessário para o acesso e o socorro, preservando-se o local quando houver interesse legal ou pericial;

h) a entrada forçada deverá ser registrada de forma objetiva, com indicação do risco, motivo, conduta adotada e condição encontrada após o acesso.

11.2 Contenção física

- a) a contenção física constitui medida excepcional e somente deverá ser empregada para preservar a vida e a segurança diante de risco imediato;
- b) a decisão deverá considerar proporcionalidade, necessidade, capacidade da equipe e insuficiência ou inviabilidade de medidas menos restritivas;
- c) o comandante da operação deverá organizar funções, segurança, atendimento pré-hospitalar e local de avaliação após a intervenção, quando houver tempo útil;
- d) deverá ser empregado o menor nível de força necessário, pelo menor tempo possível, sem finalidade punitiva, disciplinar ou de constrangimento;
- e) após a contenção, deverão ser avaliados condição geral, eventuais lesões, necessidade de atendimento pré-hospitalar e encaminhamento à unidade de urgência;
- f) a medida deverá ser registrada com justificativa, conduta adotada, recursos empregados, condição do tentante e equipe responsável.

11.3 Contenção mecânica

- a) a contenção mecânica constitui medida excepcional e deverá observar necessidade, proporcionalidade, segurança e menor restrição possível;
- b) somente deverá ser utilizada para prevenir dano imediato quando medidas menos restritivas forem insuficientes ou inviáveis;
- c) é vedado seu emprego com finalidade disciplinar, punitiva, coercitiva ou por conveniência operacional;
- d) a aplicação não poderá comprometer respiração, circulação ou integridade física e deverá ser acompanhada de monitoramento contínuo;
- e) a equipe de saúde deverá ser acionada diante de risco clínico, agitação intensa, intoxicação, alteração relevante do comportamento ou necessidade de avaliação especializada;
- f) a medida deverá ser registrada com justificativa, período aproximado de utilização, monitoramento realizado, condição do tentante e equipe responsável.

11.4 Contenção farmacológica

- a) a contenção farmacológica não constitui atribuição ordinária da guarnição BM;

b) a decisão e a execução de contenção farmacológica competem exclusivamente a profissional de saúde habilitado, vinculado ao SAMU, serviço de saúde ou serviço regulado competente, conforme competência legal e protocolo próprio;

c) quando houver indicação de contenção farmacológica, a guarnição deverá acionar o recurso de saúde competente, manter segurança da cena e apoiar a atuação dentro de suas atribuições;

d) a atuação da Gu BM deverá limitar-se à segurança da cena, proteção da equipe de saúde, apoio operacional, atendimento pré-hospitalar dentro de sua competência e continuidade das medidas de salvamento, quando necessárias;

e) a guarnição deverá registrar o acionamento do recurso de saúde, a orientação recebida, a equipe ou profissional responsável e a transferência do cuidado assistencial à equipe competente;

f) não deverá haver indicação, administração ou sugestão de medicamento por bombeiro militar fora de sua competência legal e protocolar.

12 TENTANTE COM LESÕES E SITUAÇÕES COM PRESUNÇÃO DE ÓBITO

A atuação da Gu BM em ocorrência envolvendo tentante com lesões ou situação com possível presunção de óbito deverá priorizar segurança da cena, avaliação conforme protocolo de APH, preservação da imagem, controle do local e acionamento dos recursos competentes, observadas a ITO 23 e a ITO 10.

A presença de lesão, agravo clínico ou início do atendimento de saúde não encerra automaticamente o risco suicida, devendo a guarnição manter avaliação contínua da cena, controle de riscos, abordagem compatível e registro objetivo das condutas adotadas.

Em ocorrência com vítima ferida ou fatal, a guarnição deverá preservar o local e os vestígios como potencial cena de interesse pericial, sem prejuízo da prestação de socorro e observadas as diretrizes da ITO 10.

12.1 Tentante com lesões

a) quando houver lesões, intoxicação, alteração de consciência, trauma, queimadura, queda, afogamento, interrupção de ato de risco ou outro agravo clínico ou traumático, deverá ser aplicada a ITO 23, sem prejuízo das diretrizes desta ITO;

b) a abordagem de dissuasão, a segurança da cena e o atendimento pré-hospitalar deverão ser coordenados pelo comandante da operação, evitando ações simultâneas desorganizadas;

c) o atendimento pré-hospitalar deverá observar avaliação primária, avaliação continuada, monitoramento, controle de agravos, decisão de transporte e transferência de cuidados, conforme protocolo específico;

d) o SAMU ou outro recurso de saúde deverá ser acionado quando houver necessidade de suporte adicional, regulação, recurso avançado, agravo clínico relevante ou conforme fluxo local;

e) o tentante lesionado, sem critérios de presunção de óbito, deverá receber atendimento pré-hospitalar e encaminhamento à UPA, pronto-socorro ou hospital de referência, conforme condição clínica, risco identificado e protocolo aplicável;

f) quando houver necessidade de atendimento imediato, a preservação de local não deverá impedir a prestação de socorro, devendo a guarnição, sempre que possível, reduzir alterações desnecessárias da cena;

g) o registro deverá conter informações objetivas sobre condição encontrada, risco observado, atendimento realizado, recurso de saúde acionado, unidade de destino, transferência de cuidados e demais dados necessários à continuidade assistencial.

12.2 Situações com presunção de óbito

A presunção de óbito deverá ser verificada exclusivamente conforme o protocolo P709 da ITO 23 vigente. Confirmada a hipótese protocolar, a guarnição deverá priorizar preservação do local e acionamento das autoridades competentes, conforme ITO 10 e fluxo local.

- a) preserve o cenário encontrado e limite alterações ao estritamente necessário para segurança, socorro ou eliminação de risco imediato;
- b) isole a área conforme necessidade operacional e controle o acesso de terceiros;
- c) registre objetivamente alterações inevitáveis da cena, autoridades acionadas e transferência ou liberação do local;
- d) evite especulação sobre motivação, circunstâncias ou responsabilidade.

12.3 Procedimentos gerais

- a) afaste, quando possível e sem prejuízo da segurança, familiares e pessoas diretamente impactadas de curiosos, registros de imagem e exposição indevida;
- b) mantenha comunicação objetiva, respeitosa e restrita às informações necessárias, sem especulação, julgamento ou atribuição de culpa;
- c) havendo necessidade aparente de apoio imediato a familiares ou pessoas diretamente impactadas, a guarnição deverá avaliar o acionamento de recurso de saúde, assistência social ou outro órgão competente, conforme fluxo local;
- d) o CVV 188 poderá ser informado apenas como recurso complementar de apoio emocional, sem substituir atendimento presencial, rede de saúde, assistência social ou demais órgãos competentes quando houver risco ou necessidade de intervenção;
- e) a preservação da imagem da vítima, dos familiares e da cena deverá orientar o isolamento, o controle de acesso e a relação com terceiros, imprensa e redes sociais;

f) em ocorrência de elevado impacto, o CBU ou chefe de serviço deverá informar aos bombeiros militares envolvidos a possibilidade de apoio institucional, conforme fluxo interno de saúde ou assistência da Corporação;

g) o encerramento da ocorrência deverá observar registro, comunicação às autoridades competentes, preservação de local, transferência de cuidados assistenciais ou liberação da cena, conforme ITO 10, ITO 23 e fluxo local.

13 ENCERRAMENTO DA OCORRÊNCIA

O encerramento da ocorrência deverá assegurar registro adequado, orientação mínima à família, pessoa de confiança ou rede de apoio, encaminhamento responsável à rede de saúde, proteção da imagem do tentante, saída honrosa, cuidado com a equipe e prevenção de exposição indevida.

13.1 Orientações aos familiares e rede de apoio

Quadro 21 — Orientações aos familiares e rede de apoio

Orientar	Evitar
Manter postura calma, presença respeitosa e escuta sem julgamento.	Culpar, expor, envergonhar, confrontar ou discutir moralidade.
Acompanhar o tentante até avaliação ou encaminhamento pela rede de saúde.	Interromper acompanhamento quando houver risco.
Retirar curiosos, reduzir exposição e preservar a saída honrosa.	Divulgar imagens, áudios, vídeos ou relatos em redes sociais.
Acionar rede de saúde, SAMU, CAPS ou serviço local indicado, conforme necessidade.	Prometer segredo absoluto ou impedir atendimento de saúde.
Observar agravamento, novas crises, intoxicação, confusão ou isolamento.	Minimizar a dor com frases como “isso não é nada” ou equivalentes.
Utilizar o CVV 188 apenas como recurso complementar de apoio emocional.	Usar o CVV 188 para dispensar avaliação presencial, rede de saúde ou acompanhamento quando houver risco.

13.2 Condução para unidade de urgência e registro

a) após estabilização da cena, o tentante deverá ser conduzido à UPA, pronto-socorro ou hospital de referência, conforme condição clínica, risco identificado, regulação local e fluxo assistencial aplicável, independentemente de o desfecho operacional ter ocorrido por abordagem de dissuasão ou abordagem tática;

b) a definição da unidade deverá considerar natureza clínica ou traumática, condição clínica, presença de lesões, intoxicação, crise psicótica, agitação, idade, vulnerabilidade e fluxos locais de regulação;

c) a condução deverá ser apresentada ao tentante como continuidade do cuidado e medida de segurança, sem tom punitivo, ameaçador ou de constrangimento;

d) para favorecer adesão à condução, o abordador poderá utilizar saída honrosa, microdecisão segura, ponte para o futuro e reforço de proteção imediata, apresentando a avaliação em unidade de urgência como próximo passo do cuidado;

e) o registro deverá conter a codificação correta da ocorrência, a linha de resolução empregada, a conduta adotada, os recursos acionados, a unidade de destino e as informações objetivas necessárias à continuidade do cuidado;

f) a linha de resolução deverá indicar, quando aplicável, abordagem de dissuasão, abordagem tática, atendimento pré-hospitalar, desistência antes da chegada da Gu BM ou outro desfecho operacional identificado;

g) utilize a codificação de ocorrência vigente no sistema institucional, conforme natureza e desfecho registrados;

h) o registro deverá evitar juízo de valor, exposição indevida, detalhamento desnecessário do método empregado ou informações sensíveis sem relevância para a continuidade do cuidado, segurança operacional ou análise estatística.

13.3 Posvenção e cuidado pós-ocorrência

a) quando a guarnição presenciar suicídio consumado, lesão grave ou ocorrência de elevado impacto emocional, o CBU ou chefe de serviço deverá avaliar a necessidade de cuidado pós-ocorrência para os militares envolvidos;

b) o CBU ou chefe de serviço deverá produzir relato objetivo do evento e encaminhá-lo ao NAIS/SAS responsável pela Unidade, para avaliação e adoção das medidas institucionais cabíveis;

c) quanto aos bombeiros militares diretamente envolvidos, a posvenção institucional compreenderá ações de suporte e encaminhamento conforme fluxo interno de saúde e assistência da Corporação;

d) oriente a equipe sobre os canais institucionais de apoio e encaminhamento após ocorrência de elevado impacto, quando necessário;

e) a posvenção e o cuidado pós-ocorrência deverão ser tratados como medidas preventivas, sem estigma e sem julgamento.

13.4 Imprensa, divulgação e prevenção do Efeito Werther

a) a comunicação sobre ocorrências envolvendo tentativa de suicídio ou suicídio consumado deverá prevenir exposição indevida, sensacionalismo, romantização, julgamento e possível efeito de imitação;

b) não deverão ser fornecidos à imprensa dados pessoais do tentante, método empregado, local detalhado, motivações presumidas, imagens, áudios, vídeos, mensagens, bilhetes, postagens ou detalhes da abordagem;

c) quando houver necessidade de divulgação institucional, a informação deverá ser feita por canal oficial, com linguagem objetiva, impessoal e restrita ao interesse público;

d) a divulgação autorizada poderá informar, de forma genérica, a natureza da ocorrência, a atuação institucional, a preservação da vida, o encaminhamento à rede de saúde e a orientação de busca de apoio;

e) a notícia ou nota institucional deverá evitar dramatização, heroificação, culpabilização de terceiros, descrição emocional sensacionalista, identificação do tentante ou exposição da família;

f) a guarnição deverá adotar medidas razoáveis para impedir captação e divulgação indevida de imagens por terceiros, sem comprometer a segurança da ocorrência;

g) a preservação da imagem íntegra e saída honrosa do tentante e deverá orientar retirada de curiosos, controle de registros e comunicação institucional.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Eduardo José Slomp. **Resgate Vertical: Manual de bolso**. 2º. ed. atual. Curitiba: Associação da Vila Militar - Departamento Cultural, 2016. 297 p.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: (DSM-5)**. 5º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 948 p.

BLIGH-GLOVER, W.Z. ; MILLER, F. P.; BALRAJ, E.K. **Two cases of suicidal electrocution**. The American journal of forensic medicine and pathology, Philadelphia, ano 2004, v. 25, ed. 3, p. 255-8, 1 set. 2004.

BOTEGA, Neury José. **Crise Suicida: Avaliação e manejo**. 1ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 302 p. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRUNHARI, Marcos Vinicius; DARRIBA, Vinicius Anciães. **O suicídio como questão: melancolia e passagem ao ato**. Psicol. clin., Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 197-213, jun. 2014. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652014000100013&lng=pt&nrm=iso. acessos em 28 dez. 2020.

COMISSÃO NACIONAL DE ABORDAGEM TÉCNICA A TENTATIVAS DE SUICÍDIO. 15 de Janeiro de 2019. **ESTATUTO DA COMISSÃO NACIONAL DE ABORDAGEM TÉCNICA A TENTATIVAS DE SUICÍDIO**, Franco da Rocha, ano 2019, 15 jan. 2019.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução COFEN nº 427, de 15 de fevereiro de 2012. Normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes**. Brasília, 7 maio 2012. Disponível em http://www.cofen.gov.br/resoluco-cofen-n-4272012_9146.html. acesso em 28 dez. 2020.

CROCE, Delton; JÚNIOR, Delton Croce. **Manual de Medicina Legal**. 6. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012.

DALGALARRONDO, Paulo. **Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais**. 3º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 505 p. GOIAS. Portaria 342, de 13 de dezembro de 2017. Aprova manual referente à atividade de Salvamento em Altura. Goiânia, 13 dez. 2017.

HALL, Edward T. **A Dimensão Oculta**. 1º. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 260 p.

MACHADO, Daiane Borges; SANTOS, Darci Neves dos. **Suicídio no Brasil, de 2000 a 2012**. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, ano 2015, v. 64, ed. 1, p. 45-54, 1 mar. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852015000100045 Acesso em 28 dez. 2020.

MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. **Instrução Técnica Operacional n.01: Padronização do Serviço Operacional**. 2ª ed. rev. Belo Horizonte: CBMMG, 2017.

MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Instrução Técnica Operacional n. 23: Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar. 4. ed. Belo Horizonte: CBMMG, 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. **Perfil epidemiológico dos casos notificados de violência autoprovocada e óbitos por suicídio entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, 2011 a 2018**.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. **Suicídio: tentativas e óbitos por intoxicação exógena no Brasil, 2007 a 2016**. Boletim Epidemiológico, Brasília, v. 50, ed. 15, Jul. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Marina_Miranda2/publication/334524337_Suicidio_tentativas_e_obitos_por_intoxicacao_exogena_no_Brasil_2007_a_2016/links/5d2f9ae9458515c11c393137/Suicidio-tentativas-e-obitos-por-intoxicacao-exogena-no-Brasil-2007-a-2016.pdf. Acesso em 09 de abril de 2020.

MUNHOZ, Diógenes Martins. **Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio**. 1. ed. São Paulo: Authentic Fire, 2018. 224 p.

MUNHOZ, Diógenes Martins. **Proposta de capacitação ao efetivo do Corpo de Bombeiros para o atendimento a ocorrências de tentativas de suicídio**. Orientador: Edison Ramos de Quadros. 2016. 82 p. Monografia (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Academia de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo, 2016.

PIAUÍ. Polícia Militar do Piauí. **Prevenção ao Suicídio: Orientação para Policiais Militares e Familiares**. Teresina, 2018.

PINTO, Richelmy Murta. **Posvenção ao suicídio para militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: estudo e proposta de Programa Institucional**. Orientador: Júlio César Tóffoli. 2020. 71 p. Monografia (Especialização em Gestão, Proteção e Defesa Civil) - Fundação João Pinheiro, Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Belo Horizonte, 2020.

QUEVEDO, João; CARVALHO, André F. **Emergências Psiquiátricas**. 3º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 333 p.

QUEVEDO, João.; IZQUIERDO, Ivan. **Neurobiologia dos transtornos psiquiátricos**. 1º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. 392 p.

RODRIGUES, Carlos Roberto; JUNIOR, Carlos Alberto De Camargo; MUNHOZ, Diógenes Martins. **Abordagem técnica a tentativas de suicídio – manual participante**. 1ª. ed. Franco da Rocha: Escola Superior de Bombeiros, 2018. 51 p.

SÃO PAULO. Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. **Coletânea de Manuais Técnicos de Bombeiros – CBMESP**. São Paulo, 2016.

SCAVACINI, Karen. **O suicídio é um problema de todos: consciência, a competência e o diálogo na prevenção e posvenção do suicídio.** Orientador: Maria Júlia Kovács. 2018. 271 f. Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

SOUSA, José Edir Paixão de. et al. **Abordagem na tentativa de suicídio: manual teórico-prático para profissionais da segurança pública.** Fortaleza: INESP, 2018.

WENZEL, Amy; BROWN, GREGORY K.; BECK, Aaron T. **Terapia cognitivo-comportamental para pacientes suicidas.** Porto Alegre: Artmed, 2010. 304 p.

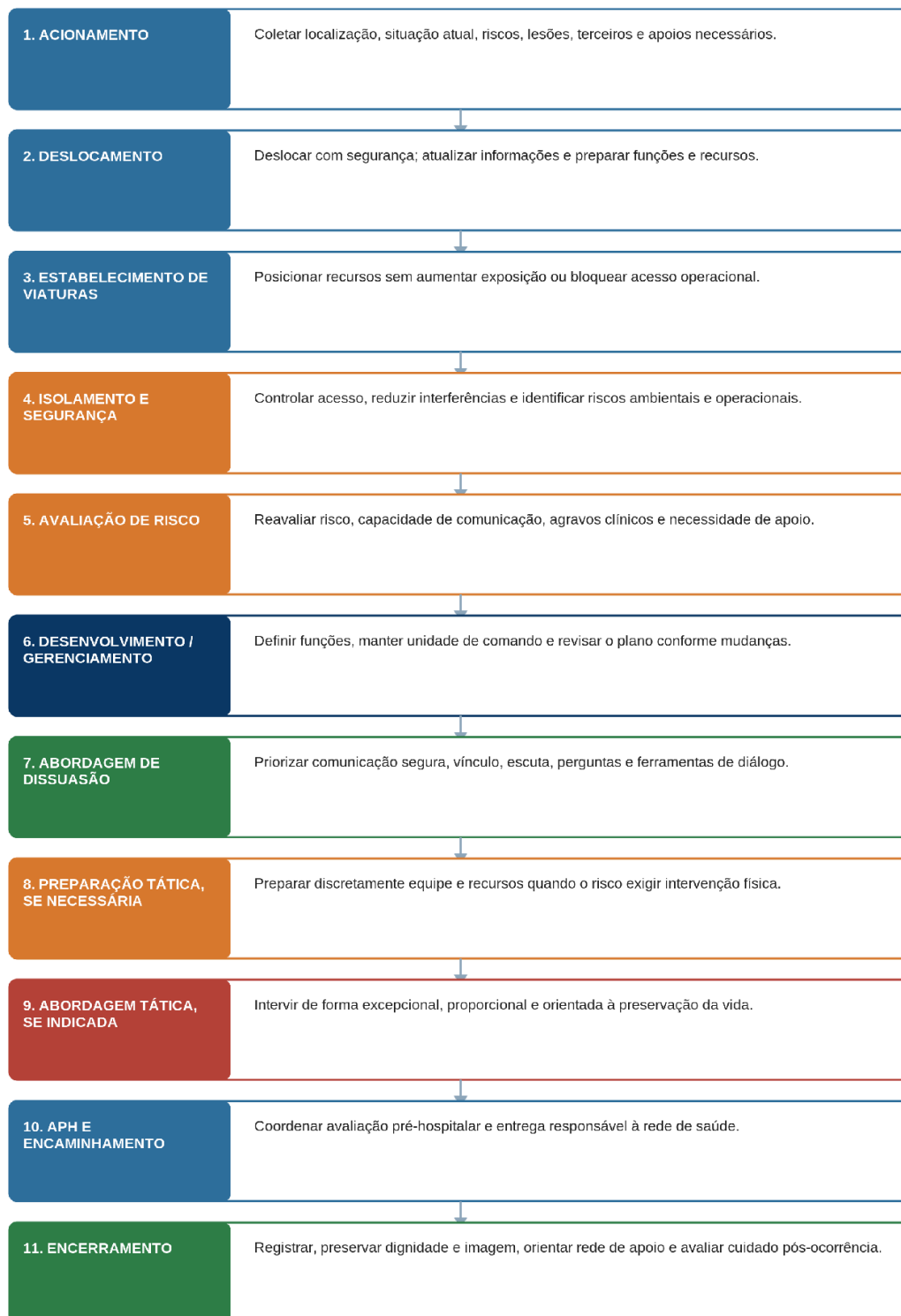
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Panorama dos suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil de 2010 a 2021. Boletim Epidemiológico, v. 55, n. 4, 6 fev. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Suicide. Geneva: WHO, 25 mar. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>. Acesso em: 7 ago. 2026.

APÊNDICE A — FLUXO GERAL DO SISTEMA ATTS

APÊNDICE A — FLUXO GERAL DO SISTEMA ATTS

Visão operacional integrada



APÊNDICE B — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: TÉCNICA DO SUCESSO ANTERIOR

APÊNDICE B — TÉCNICA DO SUCESSO ANTERIOR

Campo	Orientação operacional
Objetivo	Reconhecer recursos já utilizados em situações difíceis, sem transformar a lembrança em cobrança.
Quando utilizar	Quando houver vínculo mínimo e a pessoa conseguir falar sobre experiências anteriores.
Como executar	Perguntar se já enfrentou situação difícil; identificar pessoas, atitudes ou recursos que contribuíram para atravessá-la.
Fala possível	"Você já passou por algum momento muito difícil antes?" "O que ajudou você naquela ocasião?" "Quem esteve com você?"
Sinais de funcionamento	A pessoa organiza a fala, identifica recurso ou apoio e mantém o diálogo.
Evitar	Cobrar força; comparar sofrimentos; prometer solução; usar a lembrança como prova de que "deveria conseguir".
Resultado esperado	Ampliar percepção de recursos disponíveis e favorecer pequena ação segura.

APÊNDICE C — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: PONTE PARA O FUTURO

APÊNDICE C — PONTE PARA O FUTURO

Campo	Orientação operacional
Objetivo	Introduzir referência concreta de continuidade por meio de rotina, hábito ou atividade previamente significativa.
Quando utilizar	Quando houver vínculo e disponibilidade para falar sobre aspectos simples da rotina.
Como executar	Identificar uma atividade habitual; explorar dia, horário, preparação ou próximo passo concreto, sem promessas.
Fala possível	"Antes desta crise, havia algo simples que fazia parte da sua rotina?" "Qual seria o primeiro passo para retomar isso?"
Sinais de funcionamento	A pessoa consegue imaginar continuidade próxima, descreve passos e permanece em diálogo.
Evitar	Futuro abstrato; otimismo vazio; promessa; cobrança de projeto de vida.
Resultado esperado	Criar referência de continuidade e favorecer permanência segura no presente.

APÊNDICE D — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: PONTE PARA O PASSADO

APÊNDICE D — PONTE PARA O PASSADO

Campo	Orientação operacional
Objetivo	Evocar lembrança segura e significativa para ampliar o foco além da crise atual.
Quando utilizar	Quando houver vínculo mínimo, menor agitação e possibilidade de narrar lembrança sem aumento de sofrimento.
Como executar	Pedir uma lembrança positiva ou neutra; explorar detalhes simples e concretos da cena, sem investigação biográfica.
Fala possível	"Você consegue lembrar de um momento tranquilo ou importante para você?" "O que estava acontecendo naquele dia?"
Sinais de funcionamento	A pessoa descreve detalhes, mantém atenção e organiza melhor a narrativa.
Evitar	Explorar memórias traumáticas; insistir se houver aumento de sofrimento; transformar em interrogatório.
Resultado esperado	Favorecer organização emocional e continuidade do diálogo.

APÊNDICE E — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: PARÁFRASE RESUMIDA

APÊNDICE E — PARÁFRASE RESUMIDA

Campo	Orientação operacional
Objetivo	Demonstrar escuta e organizar o discurso por meio de devolução breve, fiel e sem julgamento.
Quando utilizar	Durante a abordagem, especialmente diante de fala repetitiva, confusa ou emocionalmente carregada.
Como executar	Ouvir; identificar o núcleo da fala; devolver em poucas palavras; confirmar se compreendeu corretamente.
Fala possível	"O que está pesando mais agora é esta sensação de não conseguir continuar assim. Eu entendi certo?"
Sinais de funcionamento	A pessoa corrige, confirma, amplia ou continua falando com menor tensão.
Evitar	Diagnosticar; opinar; completar a história; repetir mecanicamente; ironizar.
Resultado esperado	Aumentar vínculo, reduzir ruído comunicacional e abrir espaço para nova pergunta ou orientação segura.

APÊNDICE F — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: EVITAR FRASES DE NEGAÇÃO

APÊNDICE F — EVITAR FRASES DE NEGAÇÃO

Campo	Orientação operacional
Objetivo	Substituir ordens negativas por orientações positivas, concretas e seguras.
Quando utilizar	Sempre que a fala puder ser formulada como indicação clara do comportamento seguro desejado.
Como executar	Dizer o que a pessoa pode fazer agora, em voz calma, com frases curtas e observáveis.
Fala possível	"Permaneça onde está e olhe para mim por um instante." "Mantenha os pés firmes aí por enquanto."
Sinais de funcionamento	A pessoa interrompe movimento, olha, responde ou mantém posição por alguns segundos.
Evitar	Gritos; ameaça; ultimato; desafio; ironia; repetição brusca de proibições.
Resultado esperado	Reduzir escalada e orientar microação segura.

APÊNDICE G — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: CONFRONTAÇÃO EMPÁTICA**APÊNDICE G — CONFRONTAÇÃO EMPÁTICA**

Campo	Orientação operacional
Objetivo	Reconhecer o sofrimento sem validar comportamento de risco como solução e sustentar limite protetivo.
Quando utilizar	Quando houver vínculo e necessidade de combinar acolhimento com orientação clara para segurança.
Como executar	Validar a emoção; reconhecer o risco; firmar limite protetivo; concentrar a conversa nos próximos minutos.
Fala possível	"Eu entendo que a dor está muito alta agora. Minha função é ajudar a manter sua segurança enquanto atravessamos estes próximos minutos."
Sinais de funcionamento	A pessoa permanece no diálogo, reduz resistência ou aceita pequena orientação segura.
Evitar	Sermão; culpa; moralização; promessa absoluta; discutir se o sofrimento é "válido".
Resultado esperado	Manter vínculo e limite de proteção sem confronto desnecessário.

APÊNDICE H — FERRAMENTA DE DIÁLOGO: MICRODECISÃO SEGURA

APÊNDICE H — MICRODECISÃO SEGURA

Campo	Orientação operacional
Objetivo	Convidar a pequena escolha imediata que reduza risco e não exija decisão complexa.
Quando utilizar	Quando houver abertura mínima, ambivalência, silêncio ou necessidade de recuperar cooperação.
Como executar	Oferecer duas opções seguras ou uma ação simples, imediata e observável.
Fala possível	"Você prefere que eu fique aqui ou um passo mais para trás?" "Consegue olhar para mim por alguns segundos?"
Sinais de funcionamento	A pessoa escolhe, responde, ajusta posição ou aceita pequena orientação.
Evitar	Oferecer escolhas inseguras; transferir comando da cena; formular perguntas extremas ou pressionadoras.
Resultado esperado	Criar cooperação progressiva e reduzir risco imediato.

APÊNDICE I — CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL DOS PERFIS

APÊNDICE I — CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL DE PERFIS

Leitura baseada em sinais observáveis; não substitui avaliação clínica.

COMPORTAMENTO AGRESSIVO

Sinais observáveis	Hostilidade, tensão, irritabilidade, resistência, movimentos bruscos e desconfiança.
Risco operacional	Escalada por confronto; risco à pessoa, equipe ou terceiros.
Adaptação	Falar pouco e com voz baixa; manter distância segura; evitar disputa de autoridade; permitir desabafo sem aderir a exigências inseguras.
Evitar	Provocação, desafio, ultimato, ironia e resposta emocional à hostilidade.

COMPORTAMENTO DEPRESSIVO

Sinais observáveis	Choro, silêncio, retraimento, lentificação, culpa, desesperança e baixa resposta.
Risco operacional	Abandono da comunicação e agravamento pouco evidente.
Adaptação	Manter presença, linguagem simples, ritmo compatível e perguntas curtas; favorecer respostas e pequenas ações.
Evitar	Pressa, sermão, cobrança de força, culpabilização e aconselhamento impositivo.

COMPORTAMENTO PSICÓTICO / DESORGANIZADO

Sinais observáveis	Fala desorganizada, medo intenso, confusão, percepção alterada e resposta imprevisível.
Risco operacional	Reação a estímulos, agitação, fuga ou interpretação ameaçadora da cena.
Adaptação	Usar linguagem concreta; anunciar ações; reduzir estímulos; não disputar a interpretação da realidade; acionar apoio de saúde quando indicado.
Evitar	Ridicularizar, confirmar crenças como fato, tocar sem aviso, aglomerar equipe.

APÊNDICE J — PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS (PSP)

APÊNDICE J — PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS

Apoio humano inicial, prático e não invasivo após ocorrência crítica.

1**PREPARAR**

Organizar o ambiente, reduzir interferências, preservar privacidade e identificar quem necessita de apoio imediato.

2**OLHAR**

Observar segurança, necessidades práticas, sinais de sofrimento intenso e capacidade de permanecer funcional.

3**ESCUTAR**

Ouvir com atenção, sem pressionar por relato detalhado e sem conduzir debriefing emocional obrigatório.

4**CONECTAR**

Aproximar a pessoa de rede de apoio, chefia, serviço institucional ou atendimento especializado quando necessário.

EVITAR

- Forçar relato detalhado da ocorrência.
- Prometer sigilo absoluto ou solução imediata.
- Interpretar reações como fraqueza ou falta de preparo.
- Substituir avaliação especializada quando houver necessidade clínica ou funcional.

Resultado esperado: proteção, estabilização prática e conexão com apoio adequado.

APÊNDICE K — PASSO A PASSO PARA O COMANDANTE DA OPERAÇÃO**APÊNDICE K — PASSO A PASSO PARA O COMANDANTE**

Fase	Ações/procedimentos
PRÉ-ATTS	Confirme acionamento; assumo comando; avalie riscos; defina funções; estabeleça isolamento; acione recursos; defina comunicação interna e plano inicial.
INTRA-ATTS	Acompanhe a abordagem; proteja o canal de comunicação; integre informações; reavalie risco; coordene recursos; decida eventual transição tática; preserve dignidade e saída honrosa.
PÓS-ATTS	Garanta APH e encaminhamento; oriente registro; preserve imagem e privacidade; oriente rede de apoio; avalie posvenção e realize fechamento operacional.

APÊNDICE L — PASSO A PASSO PARA O ABORDADOR**APÊNDICE L — PASSO A PASSO PARA O ABORDADOR**

Fase	Ações/procedimentos
PRÉ-ATTS	Receba informações; observe antes de falar; identifique riscos; aproxime-se progressivamente; mantenha postura não ameaçadora; prepare apresentação pessoal.
INTRA-ATTS	Apresente-se; mantenha voz calma; respeite pausas; formule perguntas compatíveis; aplique ferramenta adequada; observe mudanças; preserve vínculo; informe ao comandante sinais relevantes.
PÓS-ATTS	Mantenha comunicação até entrega segura quando útil; favoreça adesão ao cuidado; evite exposição e comemorações; repasse informações objetivas à equipe responsável.

APÊNDICE M — SEGURANÇA NO ATTS

APÊNDICE M — SEGURANÇA NO ATTS

Fase	Checklist de segurança
PRÉ-ATTS	Avalie altura, água, fogo, eletricidade, produto perigoso, confinamento, arma, agressor, trânsito, terceiros, rota de retirada, EPI, viaturas, recursos e comunicação interna.
INTRA-ATTS	Mantenha isolamento; controle curiosos e imprensa; proteja abordador e tentante; mantenha equipe tática discreta; acompanhe riscos ambientais e mudanças de comportamento; preserve a diade.
PÓS-ATTS	Garanta condução segura; coordene APH quando indicado; entregue à rede; registre; proteja imagem; avalie necessidade de posvenção e recomposição da equipe.